

Programme National d'Immunisation

Guide de formation des gestionnaires en planification des activités de vaccination

Remerciements

Remerciements à tous les auteurs et collaborateurs qui ont participé à la rédaction et à la relecture de ce document qui a été rédigé à travers la revue et l'adaptation du cours de formation en gestion des cadres des programmes de vaccination élaboré par l'OMS.

L'adaptation et la rédaction ont été faites par l'équipe de la Direction de la Population.

- **Dr. LAHLOU KHALID** : Directeur de la Direction de la Population
- **Dr. YAHYANE ABDELHAKIM** : Chef de la Division de la Santé Maternelle et Infantile
- **Dr. LYAGHFOURI AZIZA** : Chef du Service de Protection de la Santé Infantile
- **Dr. BENZAOUZ MOHAMMED** : Responsable du PNI.
- **Dr. AGHOUTANE MAJDA** : Médecin Epidémiologiste au PNI.
- **Dr. OULED EERKHIS RACHIDA** : Pharmacienne au PNI.
- **Dr. EL MAAROUFI LOUBNA** : Médecin au service de la Protection de la Santé Infantile.
- **Mme ELHACHIMI ZAHRA** : Statisticienne au PNI.
- **Mme ELAMRANI IMANE** : Cadre au PNI

Des remerciements particuliers sont adressés au comité de lecture :

- **LAILA ELAMMARI** : Responsable de l'unité de Nutrition, Direction de la population.
- **ACHARI LAILA** : Chef de service de la santé de la mère.
- **Dr. BOUHMADI BRAHIM** : Responsable de l'unité de la violence, Direction de la population.
- **Dr. DGHOUGH NOUZEHA** : Médecin Epidémiologiste, Direction de la population.
- **Dr. AOUI HICHAM** : Médecin Epidémiologiste. Service de santé publique et de surveillance épidémiologique, Région de Tanger- Tétouan- Al-Hocima.
- **Dr. KHOUCHOUA MOHAMMED** : Médecin Chef du SIAAP, Préfecture de Meknès.
- **Mr. LEFTOUHI ABDESSELEM** : Animateur du PNI, Préfecture de Meknès.
- **Dr. BEN ALI LAROUCI HABIBA** : Enseignante à l'ISPISTS .Rabat.
- **Dr. GHAZOU CHAFIKA** : Médecin Généraliste, Préfecture de Fès.

Abréviations et acronymes

BCG	Bacille Calmette-Guérin (vaccin contre la tuberculose)
CQ	Concours Qualité
CSCI	Initiative de certification des chambres froides
DTC	Diphtérie, tétanos, coqueluche (vaccin)
Hep B	Vaccin contre l'hépatite B
Hib	Vaccin contre l' <i>Haemophilus influenzae</i> de type b
IEC	Information, éducation, communication
PNI	Programme National d'Immunisation
PFA	Paralysie flasque aiguë
OMS	Organisation mondiale de la santé
SIDA	Virus de l'immunodéficience humaine
SWOT	Forces, faiblesses, opportunités et menaces
UNICEF	Fonds des Nations Unies pour l'Enfance
VAT	Vaccin antitétanique
VPO	Vaccin polio oral
VPI	Vaccin antipoliomyélitique inactivé

Abandon: L'abandon est la comparaison entre le nombre d'enfants ou de femmes qui commencent à recevoir une vaccination et le nombre d'enfants ou des femmes qui ne reçoivent pas les doses suivantes pour une vaccination complète.

Activités : Ce sont des interventions nécessaires à la réalisation de chaque objectif, réparties dans le temps et l'espace dans le plan de travail.

Buts : Ce sont les modifications et les améliorations que le PNI doit effectuer pour accomplir sa mission et la définition des avantages que les populations cibles obtiennent du PNI.

Cible : Objectif spécifique et quantifiable devant être atteint dans un délai donné

Cibles : Catégories exprimées exclusivement en termes mesurables par rapport à chaque objectif. Elles sont limitées dans le temps et ont une date limite spécifique pour atteindre le niveau ou le résultat escompté.

Contraintes : Difficultés ou obstacles éventuels que l'on peut rencontrer lors de l'exécution du plan. Elles sont souvent liées aux objectifs, aux activités ou aux ressources.

Alternatives : Les alternatives sont des solutions de rechange à apporter à chaque contrainte.

Couverture vaccinale : Proportion d'individus vaccinés au sein de la population cible.

Evaluation : Estimation périodique de la situation générale du programme : performance, efficacité et efficience. Elle est liée aux politiques, aux processus, aux systèmes dans le cadre desquels fonctionne le programme, aux choix stratégiques, aux résultats et à l'impact.

Indicateurs : Variables qui indiquent les progrès ou les changements opérés vers l'atteinte des objectifs.

Micro-plan : Traduction du plan annuel en plan détaillé avec les activités, le calendrier de mise en œuvre, les ressources humaines, matérielles et financières au niveau de la Préfecture /Province ou de la formation sanitaire.

Mise en œuvre : Acte consistant à entreprendre réellement une action projetée et planifiée.

Mission : Description du type d'organisation (ex. : le PNI), sa principale raison d'être et ses valeurs.

Objectifs : Résultat final qu'un programme, un projet ou une institution vise à atteindre. Produits quantifiables ou changements positifs attendus de la mise en œuvre d'un plan.

Occasion manquée : Elle survient quand le Professionnel de santé ne profite pas l'occasion du contact avec des femmes en âge de procréer ou d'un membre de la famille pour une vaccination ciblée d'un enfant ou d'une femme.

Plan annuel : Plan qui couvre la période qui commence en janvier et se termine en décembre de chaque année et qui prend les orientations de la stratégie sectorielle.

Plan d'action : Document qui définit des activités destinées à aboutir à un résultat/produit dans le cadre d'un programme spécifique en identifiant 'qui' fait 'quoi' 'quand', 'comment' et pour 'combien'.

Plan financier : Etat prévisionnel des recettes et des dépenses. Il comporte des objectifs, des services et leurs cadres budgétaires.

Plan pluriannuel : Un plan pluriannuel couvre la période définie par la stratégie sectorielle. Le plan fournit les potentiels de ressources permettant d'atteindre les buts et objectifs stratégiques (ex. : des niveaux de la couverture de routine du PNI supérieurs à 95% ou l'arrivée au niveau de la certification pour l'éradication de la polio, etc.).

Population inaccessible : Population habitant des endroits difficiles d'accès tout au long de l'année ou durant certaines périodes de l'année (ex : saison des pluies)

Programme : Entité cohérente des projets, stratégies ou des services liés qui sont dirigés par un groupe de personnes en vue d'atteindre des objectifs spécifiques.

Progrès : Étape atteinte vers la réalisation d'un objectif ou d'un but.

Projet : Ensemble d'activités planifiées en vue d'atteindre des objectifs spécifiques par le personnel du projet dans le cadre d'un budget donné et ayant un commencement et une fin définie.

Repère : Etape (ou station) significative de réalisation d'une activité en cours.

Ressources : Ensemble des moyens matériels, financiers, humains nécessaires pour mener les activités planifiées.

Stratégie : Description de la manière dont les buts du PNI seront atteints, à savoir les types des services ou les méthodes d'intervention.

Suivi : Processus systématique et continu d'examen des données, des procédures et des pratiques en vue d'identifier des problèmes, élaborer des solutions et guider des interventions. Le suivi s'effectue fréquemment et régulièrement (base journalière, hebdomadaire, mensuelle, trimestrielle). Il est lié à la mise en œuvre des activités du programme. Les informations recueillies sont utilisées pour suivre continuellement les activités du programme.

Suivi rapide : Etat d'avancement produit par les services déconcentrés et commandé par le PNI en vue de suivre sur une période bimensuelle l'évolution des activités programmées et la consommation des ressources disponibles.

Chapitre 1 : planification des activités de vaccination :	13
I. Introduction :	15
II. Les principes et les concepts de base de la planification dans le PNI :	16
1. La mission du PNI :	16
2. Typologie du processus de la planification :	17
3. Organisation du processus de la planification :	19
4. Les éléments du Plan stratégique/ opérationnel :	20
4.1. Identification des problèmes : analyse de la situation/évaluation initiale :	21
a. Etapes de l'analyse de la situation	21
b. Analyse de l'environnement externe	21
c. Analyse de l'environnement interne	23
d. Identification des problèmes à travers l'analyse FFOM	25
4.2. Sélection des priorités	27
4.3. Formulation des objectifs :	28
a. Objectifs généraux	28
b. Objectifs et cibles spécifiques d'ici la fin de l'année	29
4.4. Détermination des stratégies et les activités :	30
a. Détermination des stratégies	30
b. Détermination des activités	32
4.5. Choix des indicateurs de monitoring et d'évaluation :	33
a. Indicateurs et étapes de leur formulation	33
b. Types d'indicateurs	33
c. Sélection et utilisation des indicateurs	34
d. Critères de sélection des indicateurs	34
e. Utilisation d'indicateurs	35
f. Indicateurs pour le suivi et l'évaluation du programme de vaccination	36
g. Indicateurs essentiels	37

4.6. Quantification des ressources et du budget :	38
a. Quantifier les ressources	38
b. Quantifier le budget	39
4.7. Utilisation du plan élaboré :	42
Chapitre 2 : Planification des activités de vaccination pour l'augmentation de la couverture vaccinale	45
I. Introduction :	47
1. Contexte :	47
2. But :	47
3. Objectifs de la formation :	47
II- Compilation des données démographiques et de couverture :	48
1. Description de la population et la zone à desservir :	48
2. Calcul de la population cible annuelle :	48
2.1. Vaccins pour enfants :	48
2.2. Pour le vaccin antitétanique :	49
2.3 Calcul de la couverture vaccinale par antigène/vaccin :	51
III- Gestion des problèmes :	51
1. Analyse des problèmes :	51
2. Identification des causes des problèmes :	54
3. Identification des solutions possibles :	54
IV- Elaboration du plan d'action pour les activités de vaccination :	57
1. Identification des activités de cette année :	57
2. Identification des Objectifs de couverture :	57
3. Définition des objectifs de vaccination :	58
3.1. Définition des objectifs de la vaccination infantile	58
3.2. Définition des objectifs pour la couverture vaccinale du VAT :	59
4. Stratégies de maintien de la couverture vaccinale de routine :	60
4.1. Stratégies de réduction des occasions manquées de vaccination	60
4.2. Stratégies de réduction des abandons	61

V- Suivi :	61
1. Outils de suivi :	61
2 .Supervision des activités de vaccination :	63
2.1-Les principes d'une supervision efficace:	63
2.2-Ce qu'il faut superviser dans le cadre du PNI:	63
2.3-Les techniques de supervision	64
3 .La vérification de la qualité des données :	64

Chapitre 1

Planification des activités de vaccination

I. Introduction :

Les orientations stratégiques actuelles pour le secteur de la santé, qui comprennent la décentralisation, le renforcement des capacités et la prise de décision au niveau des régions relative au Programme National d'Immunisation (PNI) confirment avec ferveur l'importance de planifier la mobilisation des ressources afin d'assurer l'efficacité des activités de vaccination.

Le gestionnaire du PNI au niveau régional et provincial doit connaître non seulement ses rôles et responsabilités dans le contexte actuel de décentralisation et d'intégration, mais aussi de définir des objectifs réalistes. Il doit être capable d'élaborer des plans en vue de mobiliser des ressources suffisantes et appropriées pour la mise en œuvre efficace des activités de vaccination avec la condition d'efficacité. Les expériences des campagnes de vaccination, en particulier celle de 2013 contre la rougeole et la rubéole, fournissent de nouvelles opportunités pour la mobilisation des ressources basée sur une planification solide. Par exemple, les 83 provinces et préfectures du pays ont obtenu des ressources extrabudgétaires pour appuyer les micro-plans locaux soit de la part des services centraux du Ministère de la Santé soit de la part de leurs partenaires.

Par ailleurs, le PNI, incite les régions et les provinces de présenter un rapport de performance annuel accompagné de plans d'action pertinents basés sur les micro-plans des circonscriptions sanitaires telles que définies dans la carte sanitaire. Cette planification doit prendre en considération les buts, objectifs et stratégies nationaux ainsi que les domaines d'action pour l'expansion et le renforcement des services de santé en général et ceux de la vaccination en particulier. Elle doit également tenir compte de tous les besoins liés aux ressources et des dépenses opérationnelles pour la prestation des services de vaccination.

Chaque plan doit être préparé avec la contribution des partenaires du PNI à tous les niveaux. Le fait d'associer tous les partenaires au processus de planification favorise l'appropriation nationale et locale et également le consensus sur les stratégies et les procédures de gestion du PNI.

Bien que le succès des campagnes de vaccination ait démontré qu'il existe une certaine capacité de planification, les revues régionales du PNI identifient toujours des faiblesses dans la planification des activités sur le terrain. Ces lacunes ont été confirmées par l'analyse des propositions de plusieurs provinces, lors des réunions régionales du PNI, qui sollicitent l'appui des services centraux du Ministère de la Santé.

La formation en planification doit permettre aux gestionnaires du PNI à tous les niveaux d'apprécier la situation existante, sélectionner les priorités, définir les objectifs, déterminer des indicateurs de suivi, évaluer et de préparer le calendrier d'activités et les ressources adéquates en vue d'atteindre une couverture vaccinale de 95% uniforme répondant ainsi aux objectifs du PNI.

Objectifs du guide :

Les acteurs impliqués dans la vaccination devraient être en mesure de Planifier les activités de vaccination à tous les niveaux en :

- Maîtrisant les fondements et les concepts de base en planification se rapportant au PNI;
- Analysant les problèmes émergeant dans leur contexte;
- Hiérarchisant les problèmes et définissant les priorités;
- Fixant les objectifs et les cibles;
- Déterminant les stratégies et les activités;
- Quantifiant les ressources et les moyens conséquents;
- Utilisant le plan élaboré (programmation et suivi des activités).
- Assurant une planification pour l'augmentation de la couverture vaccinale
- Maîtrisant les outils de suivi de la couverture vaccinale

Public cible :

Ce guide est destiné principalement aux gestionnaires du PNI du niveau national, régional, provincial et de la circonscription sanitaire.

II. Les principes et les concepts de base de la planification dans le PNI :

1. La mission du PNI :

La phase préparatoire du processus de la planification consiste à préciser la vision unique et stratégique du PNI, ses buts et ses priorités. Il faut garder à l'esprit que :

- Le PNI est un programme en interaction avec les autres programmes sanitaires et il est lié aux réformes en cours du Ministère de la santé ainsi que des changements qui s'opèrent dans son environnement externe (changements démographiques, épidémiologiques, macroéconomiques, politiques et autres).
- Les opérations du PNI comprennent la vaccination, la gestion, le financement et le développement des capacités. Les opérations de vaccination comprennent elles-mêmes : les prestations des services de vaccination, l'approvisionnement et la qualité des vaccins, la logistique, la surveillance épidémiologique, la notification des effets indésirables post vaccinaux, le suivi évaluation, le plaidoyer et la communication.

L'énoncé de la mission du PNI peut être résumé de plusieurs façons, notamment comme suit :

- Contribuer à la réduction de la morbidité et de la mortalité néonatales et infanto juvéniles.
- Contribuer à la réduction des handicaps évitables, cancers.... (convergence des politiques publiques).

2. Typologie du processus de la planification :

- Selon l'organisation du système national de santé, la planification du PNI peut être **centralisée** ou **décentralisée**.
- La planification est centralisée lorsque c'est le plan national qui prime et engendre ainsi les plans régionaux qui sont déclinés par des plans d'action provinciaux voir de circonscription sanitaire (planification sommet-base).
- Dans la planification décentralisée, les plans régionaux engendrent les plans provinciaux qui, à leur tour, constituent le plan national (planification base-sommet).
- Selon les niveaux du système national de santé, la planification peut être **stratégique** ou **opérationnelle**.

La durée et le contenu des plans varient en fonction de leur typologie, comme le montre le tableau 1 ci-après :

Tableau 1 : Principales caractéristiques de divers types des plans :

Caractéristiques	Plan stratégique	Plan opérationnel / d'action
Fréquence ou périodicité	Trois à cinq ans ou plus	Annuel ; semestriel ; trimestriel
Contenu/principaux éléments	Enoncé de la vision du PNI Analyse de la situation Buts et objectifs à long terme Politique et stratégies du PNI Domaines d'activités prioritaires Calendrier de mise en œuvre Monitoring des indicateurs proposés Calendrier d'évaluation Besoins généraux en ressources par composantes	Objectifs opérationnels annuels et résultats attendus Activités détaillées Calendrier ou chronogramme des activités Monitoring des indicateurs proposés Personnes ou institutions responsables de l'exécution de chaque activité Budget et besoin en ressources Source de financement Supervision
Responsable général de la mise en œuvre.	Responsable du PNI	Les gestionnaires du PNI à différents niveaux

- La planification stratégique est une planification à long terme qui couvre une période de trois à cinq ans et qui consiste à déterminer les buts , les objectifs et les stratégies d'interventions. Les plans stratégiques sont élaborés par le niveau central du Ministère de la Santé et servent de référence pour les niveaux régionaux et provinciaux.

- cohérence à la planification aux services déconcentrés, le programme national doit développer un Plan stratégique national qui décrit les politiques, les objectifs à long terme et les stratégies générales du programme.
- La planification opérationnelle qui se fait au niveau régional et provincial est l'expression concrète du plan stratégique. C'est l'épine dorsale de la mise en œuvre, de l'action et des interventions sur le terrain.
- Les micro-plans annuels (province et circonscriptions sanitaires) constituent le fondement permettant le suivi de la mise en œuvre du plan national.
- A l'aide des stratégies et de la politique nationales, les provinces et régions doivent déterminer avec soin leurs besoins et leurs ressources ainsi que les stratégies et activités permettant de réaliser les objectifs du PNI.

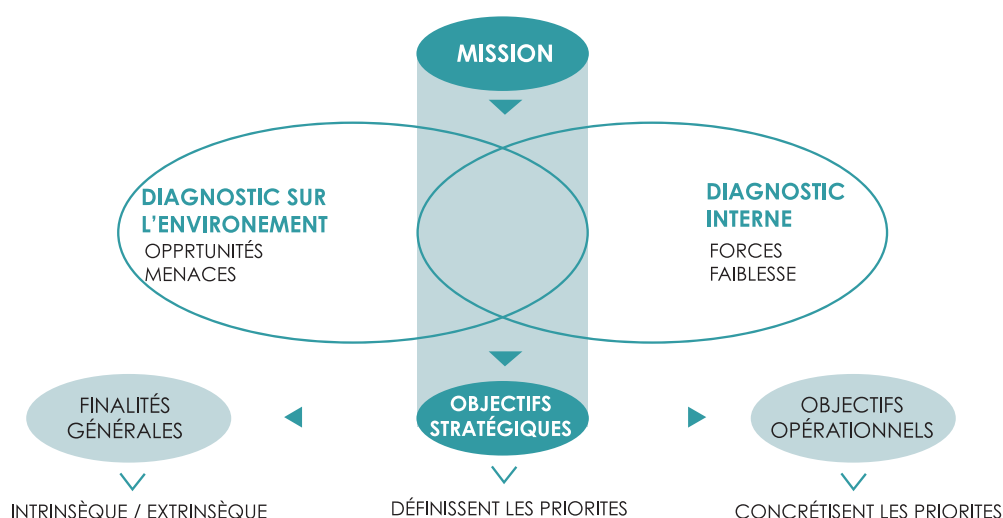
Dans le cas où la gestion et certains financements des activités du PNI sont décentralisés, les régions et provinces informent le niveau central de leurs plans et besoins, au lieu d'attendre des ressources et des instructions.

Avec des données plus exactes fournies par les régions et provinces, le programme national peut élaborer plus efficacement le Plan annuel du PNI. Ce plan d'action basé sur les données compilées à partir des micro-plans des circonscriptions sanitaire décrira plus en détail les activités et ressources devant contribuer à la réalisation des objectifs du PNI pour l'année en question.

Les trois stades du processus de planification du PNI à savoir : l'élaboration du plan stratégique national à long terme, le micro-plan annuel des circonscriptions sanitaires et le plan d'action national annuel du PNI sont interdépendants.

La figure 1 illustre le processus de planification, c'est-à-dire les étapes séquentielles à suivre lorsqu'on prépare des plans.

Figure 1 : Illustration du processus de planification



Le schéma ci-dessus présente le séquençage du processus de planification allant de la définition de la mission de la politique jusqu'aux objectifs opérationnels.

Établir des priorités, c'est choisir entre différentes options ; cette prise de décision a une conséquence directe sur les résultats de votre politique ou stratégie d'action. Les processus décisionnels comportent toujours des éléments à la fois objectifs et subjectifs souvent imprégnés des contraintes politiques à court terme. Afin de réduire la marge d'erreur, il convient de privilégier la part des éléments objectifs de manière à donner des fondements rationnels à vos choix. Il est impossible de considérer toutes les options existantes ni de trouver la meilleure solution mais simplement de choisir la solution satisfaisante pour résoudre le problème posé. Ainsi, la priorité d'une politique n'est pas d'obtenir le rendement maximal des ressources, mais plutôt le rendement optimal compte tenu du contexte.

À ce titre, la finalité d'une politique de vaccination n'est pas seulement d'obtenir un taux de couverture optimal mais aussi, dans le cadre de la convergence des politiques publiques, de soutenir la politique de réduction des décès et de l'handicap en général. Une telle politique doit intégrer la mission de prévention des pathologies à l'origine de l'handicap et ainsi mettre en œuvre des actions visant à préserver la santé dans sa définition large. Il s'agit donc de trouver un juste équilibre entre les exigences économiques et les impératifs sociaux.

L'étape finale du processus d'établissement des priorités devra inclure des moments de concertation et de communication avec les acteurs les plus importants du domaine, y compris les autres instances publiques du gouvernement. Ce dernier aspect est essentiel car les dispositions favorables et proactives de l'environnement et du personnel maximiseront les chances de réussite du programme. Les accords et les résistances qui se dessineront à cette période seront un indicateur valable de son possible succès.

3. Organisation du processus de la planification :

Pour être performant, tout programme doit avoir une vision claire de l'avenir, c'est-à-dire de son développement, et ensuite un plan construit décrivant les activités immédiates et celles futures, pour traduire cette vision en réalité.

La planification du PNI se définit comme un processus continu d'analyse des données, d'évaluation des résultats, des contraintes et de prise de décisions pour atteindre les objectifs.

L'exercice de planification du PNI doit permettre de mieux comprendre le programme, ses buts, ses stratégies ainsi que les activités et les ressources nécessaires pour atteindre ces buts.

Les plans doivent répondre aux questions suivantes :

- Quelle est la vision du PNI ?
- Quelle est la situation actuelle du PNI au niveau national et provincial ?
- Comment le faire (quelles stratégies seront utilisées?)
- Comment les activités de soutien du PNI seront-elles financées au niveau locorégional?
- Comment les activités du PNI seront-elles suivies et évaluées?

En tant que processus complexe et capital, la planification exige des compétences, des moyens et du temps.

D'emblée, il est important de comprendre que le processus de planification permet de dévoiler tous les problèmes qui se posent au PNI et d'élaborer des stratégies qui permettront d'y apporter des réponses.

Les défis les plus fréquents et actuels sont les suivants :

- Comment augmenter la couverture vaccinale?
- Comment maintenir la qualité des prestations de vaccination?
- Comment réduire les occasions manquées?
- Comment résoudre les questions liées à l'introduction des nouveaux vaccins?

Le processus de planification exige un travail d'équipe. Le choix des membres de l'équipe de planification dépend du type de planification envisagée. Généralement, il faut d'abord constituer l'équipe de planification qui englobe aussi bien les décideurs, les intervenants/partenaires, les prestataires et les bénéficiaires. Il faut veiller dès le départ à ce que tous les membres de cette équipe aient une même compréhension du programme de vaccination, des problèmes auxquels il fait face et de la vision de l'avenir. Tout le monde doit être motivé.

4. Les éléments du Plan stratégique/ opérationnel :

Tous les plans qu'ils soient stratégiques ou opérationnels doivent contenir les éléments suivants :

⇒ **Contexte**

- Géographique.
- Socioéconomique.
- Profil sanitaire .

⇒ **Analyse de la situation du PNI**

- Situation actuelle.
- Problèmes et priorités .

⇒ **Objectifs:**

⇒ **Cibles:**

⇒ **Stratégies:**

⇒ **Activités** (couvrant la vaccination de routine, la surveillance et la vaccination supplémentaire : campagnes) et leur calendrier.

⇒ **Ressources nécessaires:**

⇒ **Budget:**

⇒ **Suivi et évaluation:**

- Méthodes et calendrier de l'évaluation.
- Description des indicateurs de suivi et d'évaluation.

4.1 Identification des problèmes : analyse de la situation/évaluation initiale :

L'analyse de la situation ou évaluation initiale consiste à recueillir des données sur les résultats du programme de vaccination. Elle sert surtout à répondre aux questions suivantes: où sommes-nous maintenant et quels sont les défis ou problèmes auxquels nous devons faire face ? Ainsi, l'analyse de la situation contribue à identifier **les besoins, les problèmes, leurs causes, leurs conséquences et leurs solutions potentielles.**

Concrètement, l'analyse de la situation identifie les aspects du programme qui nécessitent une amélioration ou un renforcement. Elle comprend l'analyse des environnements externes et internes. C'est un examen exhaustif qui doit être effectué en équipe.

a. Etapes de l'analyse de la situation :

- **L'étape 1** : englobe toutes les activités d'initiation du processus, de conception d'outils d'analyse et de programmation des activités de la collecte des données.
- **L'étape 2** : comprend la collecte des données à travers des revues documentaires, des entrevues avec les informateurs clés .
- **L'étape 3** : analyse et traitement des données qui regroupe la compilation des données et l'interprétation des résultats.
- **L'étape 4** : préparation du rapport d'analyse de la situation, qui doit avoir des chapitres sur le contexte, la méthodologie et présenter les conclusions et principales recommandations.

b. Analyse de l'environnement externe :

L'analyse de l'environnement externe explore les quatre domaines suivants :

- Politique, économie, culture et santé.
- Tendances démographiques de base.
- Offre et demande des services de vaccination.
- Ressources et leurs sources de financement.

Plus de détails dans ce chapitre portent sur les éléments ci-après :

- **Carte administrative** du pays/région/province, indiquant les différentes provinces et régions voire des circonscriptions sanitaires.
- **Politique de l'enfance** (situation relative à la protection des droits de l'enfant).

– Situation économique :

- Loi de finance et évolution du budget.
- Financement du PNI au cours des cinq dernières années.
- Réseaux des communications, ex. : routes, téléphone, radio et télévision, presse écrite etc.
- Disponibilité des différentes sources d'énergie (électricité, gaz, énergie solaire, etc.)

– Données socioculturelles :

- Croyances et tabous liés à la vaccination.
- Statut familial des femmes et des enfants dans la famille.

– Données démographiques (préciser la source et l'année de référence).

- Population totale (préciser la source et l'année de référence).
- Taux d'accroissement annuel.
- Proportion de la population urbaine/rurale.
- Pyramide des âges de la population (femmes en âge de procréer, enfants <1an, < 5ans, <14 ans).
- Taux de fécondité.
- Taux de mortalité maternelle.
- nombre d'enfants vivants.
- taux de mortalité infantile.

– Accès et prestations des services de santé :

- Accessibilité aux services de santé dans les zones urbaines et rurales.
- Couverture des soins prénataux.
- Ratio médecin/population, infirmier formé/population.
- Introduction d'autres interventions de santé pouvant bénéficier au programme de la vaccination (programme de santé dans le milieu rural) .
- Initiatives de réformes dans le secteur de la santé et d'autres secteurs (carte sanitaire).

– Ressources et sources de financement :

- Budget alloué aux activités de la vaccination.
- Vaccin et logistique.
- Infrastructures et équipements.
- Ressources humaines pour la vaccination aux niveaux central, intermédiaire et local.

- Coûts des vaccins.
- Participation communautaire, contribution des intervenants et partenaires de la vaccination (INDH,.....).

c. Analyse de l'environnement interne :

Les données relatives au PNI doivent être recueillies et analysées en vue d'identifier les problèmes et de définir les priorités. L'analyse de l'environnement interne doit répondre à la question : Où sommes-nous actuellement ? Elle doit aussi définir la situation interne avec ses tendances au cours des années précédentes et montrer ses interférences avec son environnement externe.

Pour effectuer cette analyse interne, la méthode d'analyse Forces - Faiblesses - Opportunités - Menaces (FFOM ou SWOT) est recommandée. C'est un outil d'analyse stratégique qui combine l'étude des forces et des faiblesses du programme avec celle des opportunités et des menaces de son environnement, afin d'aider à la définition d'une stratégie de développement.

⇒ Directives pour l'évaluation des services de vaccination :

Tous les planificateurs du PNI doivent utiliser les directives pour l'évaluation des services de vaccination, qui décrivent une nouvelle méthodologie de collecte des données sur les forces et les faiblesses des services de vaccination et la manière dont ils peuvent être améliorés et pérennisés à travers:

- L'augmentation et l'utilisation des services de vaccination de routine, en particulier dans les zones peu accessibles.
- L'introduction des nouveaux vaccins et de nouvelles technologies.
- L'assurance d'un financement suffisant et durable en particulier pour les activités de soutien (par exemple la gestion des déchets de la vaccination).

Les directives recommandent la collecte des données suivantes sur :

– Les maladies cibles du PNI :

- Tendance des morbidités et mortalité.
- Taux de fécondité.
- Nombre de cas de rougeole et leur répartition par tranche d'âge.
- PFA notifiées et vérifiées.
- Nombre de cas de tétanos néonatal et répartition géographique.
- Système de notification des maladies cibles du PNI, y compris complétude et promptitude des rapports, gestion de l'information, rétro-information au niveau opérationnel et actions de suivi
- Préparation et réponse aux épidémies.
- Rôle du laboratoire national de référence

– Offre et demande des services de vaccination

- Politiques de vaccination, vaccins pour administration et calendrier.
- Nombre et type d'établissements de santé et leur répartition (rural, urbain).
- Nombre et type de points de vaccination (stratégie mobile).
- Population cible pour le PNI de routine : enfants de 0 à 11 mois, femmes en âge de procréer.

– Stratégies de vaccination :

- Stratégies fixe et mobile et proportion de la population couverte par chacune des stratégies.
- Stratégies appliquées pour la réduction des occasions manquées (mini campagnes)
- Stratégies de vaccination pour l'accès aux populations difficiles à atteindre, etc.

– Couverture vaccinale :

- Couverture nationale au cours des cinq dernières années (données de routine ou d'enquêtes de couverture)
- Couverture réalisée pendant les activités de vaccination supplémentaire

– Vaccins et autres fournitures :

- Nombre et durée des ruptures de stocks des vaccins ou des fournitures au cours de l'année actuelle et de l'année passée.
- Mécanismes de distribution des vaccins et des fournitures.

– Sécurité des injections :

- Politique nationale sur les types du matériel d'injection.
- Approvisionnement en matériel d'injection.
- Destruction du matériel d'injection.

– Chaîne de froid

- Type, quantité et état du matériel de la chaîne de froid.
- Existence d'un inventaire actualisé de la chaîne de froid, y compris la périodicité de l'inventaire, le programme d'entretien et de remplacement du matériel.
- Pourcentage d'établissements de santé disposant d'un réfrigérateur âgé de moins de 5 ans.

– Autre matériel et logistique

- Quantité et état du matériel : véhicules tout terrain, utilitaires, etc. à différents niveaux.
- Programme d'entretien et de remplacement du matériel.
- Plan de transport.
- Etat de la gestion des véhicules

– **Communication et mobilisation sociale :**

- Stratégies et mécanismes de communication en faveur du programme.
- Activités de mobilisation sociale et d'IEC pour la vaccination de routine.
- Surveillance active pour la notification des maladies cibles.

– **Gestion du programme :**

- Place du PNI dans la structure du Ministère de la Santé, ex. : autonome ou intégré dans les SSP et place du PNI dans la structure de la Région et la Province.
- Renforcement des capacités : effectifs et qualifications du personnel, opportunités de formation, répartition, conditions de travail dans les formations sanitaires.
- Démarches de progrès (Concours Qualité et accréditation) et supervision à différents niveaux (méthode, outils et périodicité)
- Coordination de toutes les opérations de vaccination, y compris la collaboration avec les partenaires et d'autres programmes.
- Mobilisation, gestion et administration des fonds.

d. Identification des problèmes à travers l'analyse FFOM :

Dans le cas de l'environnement interne, les composantes de l'analyse FFOM combinent les forces et les faiblesses. Dans le cas de l'environnement externe, les composantes sont les opportunités et les menaces (voir les éléments FFOM du tableau 2 ci-dessous).

Le contexte et la situation du PNI dans le pays/province conduiront à l'analyse des facteurs considérés comme les forces et les faiblesses du PNI, ainsi que les opportunités (facteurs favorables ou positifs) et les menaces (obstacles ou facteurs négatifs) liées aux activités de vaccination.

Tableau 2 : Composantes de l'analyse FFOM

Environnement			
		Interne	Externe
Orientation/influence	Positif	Forces	Opportunités
	Négatif	Faiblesses	Menaces

L'analyse des forces et des faiblesses internes du PNI s'intéressera en particulier aux domaines suivants :

- **Capacités de gestion :** structure, planification, coordination, gestion du personnel, supervision, formation, système d'information et de gestion, gestion des ressources matérielles.
- **Capacités de programmation et d'évaluation :** prestation de services, formation, communication, évaluation de la performance, qualité des services, recherche, etc.
- **Capacités financières :** budget de fonctionnement et soutien aux missions, participation communautaire, pérennité...

La seconde phase de l'analyse FFOM mettra en exergue les opportunités et les menaces liées à l'environnement externe.

Voici quelques exemples pour illustrer l'analyse FFOM :

- Le bon fonctionnement du système de la chaîne de froid, permettant de disposer de vaccins actifs, pourrait, par exemple, constituer une force du programme.
- Un mauvais système de maintenance des véhicules, de la chaîne de froid ou le manque de supervision, limitant la communication entre le SIAAP et le personnel sur le terrain, pourrait être une faiblesse.
- Le financement d'activités spécifiques du PNI par exemple une formation sur la gestion des déchets par un partenaire ou une société savante pourrait constituer une opportunité.
- La menace viendrait du fait que la non prise en compte en termes d'IEC et de prise en charge préventive de certains événements indésirables connus pourrait être hostile à la vaccination.

L'analyse de la situation conduira à la définition des stratégies nécessaires à la planification des activités du PNI avec un accent sur les faiblesses identifiées:

- Planifier la supervision et le transport des équipes de vaccination.
- Planifier l'IEC avec des stratégies spéciales pour les non-utilisateurs des services de la vaccination.
- Accroître la participation des partenaires à la vaccination pour les populations peu accessibles.
- Organiser la formation en cours d'emploi du personnel de santé.

*** Identifier les problèmes dans les systèmes de vaccination :**

À la fin, vous devriez avoir identifié les principaux problèmes qui touchent les systèmes de vaccination au sein de votre Région /Province surtout ceux qui touchent les opérations de vaccination, en particulier la vaccination de routine, la vaccination supplémentaire et la surveillance.

NB : Vous pouvez aussi consulter les documents de politiques et les plans stratégiques de lutte contre certaines maladies (polio, rougeole, tétanos néonatal)

Rédigez le document sur le contexte et l'analyse de la situation :

En se référant à la problématique du PNI telle que présentée dans le Plan stratégique régional ainsi que dans votre circonscription sanitaire, répondez aux questions générales et subsidiaires de l'étude de cas suivant :

Etude de cas:

En tant que responsable nouvellement nommé au PNI au niveau régional ou provincial, on vous a fourni les données démographiques et sanitaires de base de la province. Celle-ci a une superficie de 90 kilomètres carrés, une population totale de 200 000 habitants dont la plupart vivent dans les zones rurales.

Les enfants âgés de moins d'un an représentent 3% de la population et les femmes en âge de procréer, 21%. La rougeole, la coqueluche et le tétanos néonatal sont fréquents. Le taux de couverture vaccinale pour les antigènes individuels varie de 28% à 68% pour chaque antigène, la couverture pour le VAT étant la plus faible, 28%, et celle pour le BCG, la plus élevée, 68%.

Vous disposez des directives et du calendrier de vaccination de votre programme

Un document écrit existe sur la politique de la sécurité des injections, mais on s'y réfère très peu. Aucun rapport ni inventaire de l'appui logistique n'est disponible.

Répondez aux questions suivantes :

- Quels sont les problèmes-clés auxquels fait actuellement face votre région/province dans le secteur de la vaccination ?
- Quels sont les problèmes des services de vaccination qui sont spécifiques à votre Région/Province?
- Quels sont les points clés que vous incluriez dans l'analyse de situation?

A partir du texte précédent sur les méthodes d'analyse de la situation et des problèmes de santé publique, identifiez :

- Les éléments de rédaction sur le contexte.
- Les éléments pour lesquels vous comptez élaborer un plan.
- A l'aide de l'analyse FFOM, identifiez les forces et les faiblesses du PNI. Y a-t-il des opportunités et des menaces ?

En tenant compte des principaux problèmes identifiés dans l'analyse réalisée ci-dessous, remplir le tableau ci-après.

Problème	Causes conséquences	Solutions possibles	Sujets à inclure / dans le plan

4.2. Sélection des priorités :

Lorsque l'on considère toutes les composantes du système de vaccination dans leur environnement interne et externe, on peut conclure que les besoins et les problèmes qui affectent le PNI sont multiples et nombreux.

Eu égard aux réalisations du PNI depuis 1987, on peut avancer que la priorité à un problème doit inclure aussi bien les critères de santé publique que ceux relevant de la gestion du programme. Il est à prendre en considération :

- Ampleur du problème.
- Gravité du problème.

- Conséquences socio-économiques.
- Population-cible.
- Faisabilité financière.
- Perception des bénéficiaires.
- Perception des intervenants et partenaires.

Il est aussi à rappeler que les besoins et problèmes prioritaires doivent être identifiés dans chaque composante du système de vaccination (prestations de vaccination, logistique, approvisionnement et qualité des vaccins, surveillance, plaidoyer et communication, gestion, développement des capacités et financement d'activités connexes).

Au Maroc, les priorités en termes de vaccination sont identifiées dans la politique générale du Programme suite à la convergence de la politique sanitaire nationale et internationale après consultation du Comité National Scientifique Consultatif de Vaccination.

4.3. Formulation des objectifs :

Commencez par répondre à cette question importante : Où voulons-nous aller ou quels sont les résultats mesurables attendus ? Il s'agit de déterminer quelles seront les meilleures solutions aux problèmes identifiés et classés par priorité à la section précédente. Ces solutions doivent être formulées sous forme d'objectifs mesurables, de cibles et de résultats escomptés.

La formulation des objectifs doit obéir aux règles et principes courants utilisés en santé publique : fixer des objectifs généraux et spécifiques, à l'aide de **verbes actifs** et transitifs directs, un **contenu**, des critères et des **conditions**.

Les objectifs et cibles spécifiques doivent avoir toutes les caractéristiques ci-dessus et être **spécifiques**, **mesurables**, **appropriés**, **réalistes** et limités dans le temps (SMART en anglais).

Les premiers objectifs à formuler sont ceux liés aux opérations de vaccination, suivis par les composantes d'appui à ces services (gestion, financement, développement des capacités).

Les orientations stratégiques internationales (OMS) et nationale (stratégie sectorielle) sur la vaccination incite au renforcement des systèmes de vaccination, accélérer la lutte contre les maladies et introduire de nouveaux vaccins et des innovations technologiques.

Un certain nombre d'exemples généraux et spécifiques sont proposés ci-dessous pour examiner les questions prioritaires du programme de vaccination.

Voici des exemples d'objectifs formulés dans le plan stratégique régional du PNI et qui peuvent être adaptés au niveau des pays.

a. Objectifs généraux :

- Renforcer/optimiser la qualité et la pérennité des services de vaccination.

- Accélérer les efforts pour réaliser l'éradication de la polio, la maîtrise du maintien de l'élimination du tétanos néonatal et l'élimination de la rougeole et du syndrome de la rubéole congénitale.
- Introduire d'une manière pérenne les nouveaux vaccins et les technologies appropriées.

b. Objectifs et cibles spécifiques d'ici la fin de l'année :

Pour le renforcement des systèmes de vaccination provinciaux:

- Au moins 90% des provinces et préfectures auront atteint au moins 95 % de couverture vaccinale uniforme.
- Toutes les provinces et préfectures auront atteint 100 % de sécurité des injections.
- Toutes les provinces et préfectures auront renouvelé 50% du matériel relatif à la chaîne de froid à travers la ligne budgétaire existante dans le budget de la santé.

Pour la lutte accélérée contre la maladie :

– Eradication de la poliomyélite :

- Aucun cas de paralysie flasque associé au poliovirus sauvage.
- Maintenir la surveillance épidémiologique réactive en notifiant au moins 2 cas de PFA pour 100000 enfants de moins de 15 ans par an.
- Le processus de certification renouvelé chaque année.

– Elimination de la rougeole :

- Maintenir un taux de couverture de 95% par le vaccin anti-rougeoleux (première et deuxième prise).
- Fournir une seconde occasion de vaccination contre la rougeole à tous les enfants par des activités de vaccination supplémentaires.
- Surveiller le statut vaccinal à la rentrée scolaire.
- Maintenir la réduction des susceptibles.
- Maintenir la surveillance épidémiologique des fièvres éruptives en notifiant au moins 2 cas suspects de rougeole / 100.000 habitants par an.

– Elimination du Tétanos néonatal (TNN) :

En mars 2002, le Maroc a été le premier pays de la Région EMRO de l'OMS à avoir validé l'élimination du TNN qui était un véritable problème de santé publique.

- Au moins 90% des provinces et préfectures auront atteint un taux d'incidence inférieur à 1 cas pour 1000 naissances vivantes.
- Maintenir la surveillance active au niveau des structures des soins à la recherche des cas de TNN.

- Maintenir un taux de vaccination par le VAT de 95% uniforme par niveau et par milieu pour les femmes en âge de procréation.

– **Élimination de la Diphtérie:**

Au Maroc, aucun cas de diphtérie n'a été détecté depuis 1992. Cependant, le risque d'apparition de cas isolés ou de foyers épidémiques existe toujours, d'autant plus que la maladie continue à sévir dans des pays voisins et d'autres pays avec lesquels les mouvements de population sont importants.

- Maintenir un taux de couverture vaccinale de routine d'au moins 95% uniforme par niveau et par milieu.
- Renforcer les rappels.
- Suivre la tendance actuelle de la maladie.

Pour les innovations :

– **Nouveaux vaccins :**

- Introduction du vaccin contre l'hépatite B dans les activités des maternités hospitalières : hépatite B à la naissance.
- Introduire le vaccin antipolio inactivé (VPI) au courant de l'année 2015.
- Retirer le VPO à l'horizon de 2020.

– **Nouvelles technologies :**

- D'ici 2020, toutes les provinces et préfectures auront introduits la nouvelle génération des réfrigérateurs pré qualifiés par l'OMS.
- La gestion des déchets de la vaccination
- Informatisation du système d'information

4.4. Détermination des stratégies et les activités :

a. Détermination des stratégies :

Les stratégies doivent tracer le chemin que le PNI doit emprunter pour atteindre ses buts et ses objectifs formulés. Il existe deux types de stratégies :

- Les stratégies de référence qui sont généralement liés aux soins de santé primaires dans son secteur de la prévention (exemple : stratégie mobile, stratégie fixe) ou aux objectifs généraux du PNI (exemple : certification, accréditation, externalisation de la gestion des déchets... etc.).
- Les stratégies opérationnelles, c'est-à-dire comment exécuter les activités ; par exemple, utiliser un programme de santé scolaire pour accroître la couverture RR dans la population féminine et assurer le contrôle et l'accomplissement de la vaccination ou le programme de surveillance de la grossesse et de l'accouchement pour arrêter la transmission verticale de l'hépatite B en vaccinant les nouveaux nés dans les maternités hospitalières et dans les maisons d'accouchement et ce dans les premières 24h après la naissance.

- L'élaboration des stratégies exige aussi un travail d'équipe, la participation des partenaires extra-département et implique l'examen de toutes les possibilités applicables à chaque but/objectif. Il est recommandé de veiller à ce que les stratégies soient pertinentes, réalisables techniquement et financièrement.

Question :

Nous utilisons d'habitude un bon exemple pour illustrer une « stratégie positive », qu'en est-il des exemples ci-dessous :

- “Pour vacciner les enfants cibles dans les localités peu accessibles, le programme utilisera régulièrement des moyens de mobilité en collaboration avec les autorités compétentes” ; ou
- “Utilisez l'appui de la commune pour assurer l'atteinte de la couverture de la population cible “ .

Considérez-vous ces stratégies comme étant pertinentes ou bonnes ?

Toutes les revues antérieures du PNI ont reconnu l'efficacité des stratégies actuellement utilisées telles que la planification, la supervision, la formation, la coordination, le suivi et l'évaluation.

La campagne RR de 2013 a mené à l'élaboration d'autres approches novatrices, notamment la micro-planification au niveau de la circonscription sanitaire, la surveillance, l'amélioration de la communication, la mobilisation sociale et communautaire en vue de réduire les occasions manquées et d'atteindre les zones reculées.

En conséquence, le plan stratégique national recommande les stratégies de référence suivantes comme moyens d'améliorer la performance du PNI :

- Engagement politique.
- Plaidoyer, mobilisation sociale et communication.
- Planification nationale et locorégionale.
- Logistique, approvisionnement et qualité des vaccins.
- Coordination des partenaires du PNI.
- Développement des capacités et formation.
- Qualité des services de vaccination.
- Gestion du programme (revue du programme, supervision, suivi et évaluation).

Le PNI propose pour les provinces, préfectures et circonscriptions sanitaires 05 composantes opérationnelles pour atteindre chaque territoire relevant d'une structure de soin :

- **Rétablissement de la stratégie mobile de vaccination** (équipe mobile de vaccination): visites régulières de stratégie mobile aux communautés insuffisamment desservies dans le cadre du calendrier national d'immunisation.
- **Supervision formative**: capacitation des vaccinateurs in situ par les superviseurs.

- **Renforcement des liens entre la communauté et le service** : communication.
- **Pilotage des activités du PNI** : à travers des tableaux de bord et des indicateurs.
- **Planification et gestion des ressources** : meilleure gestion des ressources humaines et matérielles.

Les services de vaccination étant actuellement fournis dans le cadre des interventions de santé pour la protection santé maternelle et infantile à travers le réseau de soins de santé primaires, tel que définie par la carte sanitaire de 2014, dans toutes les provinces et préfectures doivent être mises en œuvre de manière intégrée en utilisant la vaccination comme plateforme pour d'autres interventions tel que celles en relation avec la nutrition, la Prise en Charge Intégrée de l'Enfant (PCIE), maladies chroniques...etc.

Le renforcement des capacités nationales pour atteindre chaque localité (ou point de rassemblement) est un fondement essentiel et une stratégie opérationnelle clé pour la mise en œuvre du Plan stratégique national du PNI.

Les stratégies opérationnelles élaborées doivent se référer aux objectifs régionaux spécifiques et en tenant compte des priorités, des conditions et des critères de chaque province et préfecture. Des stratégies pour chaque composante des programmes de vaccination doivent aussi être élaborées pour rendre le plan plus précis et spécifique.

b. Détermination des activités :

Pour chaque objectif et chaque cible spécifique formulé et inclu dans chaque composante du programme de vaccination, il est essentiel de déterminer les activités spécifiques qui lui sont relatives.

Les activités se formulent sous forme de verbe d'action et elles sont complément d'objet direct.

Exemple :

- Commander les vaccins.
- Concevoir les outils de supervision.
- Former les vaccinateurs.
- Administrer les vaccins.
- Programmer les activités de supervision.

Les activités du PNI sont classées en activités techniques, qui sont liées aux opérations de vaccination, et en activités d'appui, qui concernent la gestion du programme, le financement et le développement des capacités.

Toutes les activités techniques et d'appui rattachées directement à un objectif spécifique sont appelés activités de programme. Ces activités sont souvent précédées d'activités préparatoires et déclenchées par des activités de lancement.

4.5. Choix des indicateurs de monitoring et d'évaluation :

Le suivi et l'évaluation du PNI sont des processus fondamentaux qui facilitent la collecte et l'analyse des données requises pour vérifier si les activités planifiées dans le cadre du programme sont mises en œuvre efficacement ou pour évaluer dans quelle mesure les objectifs et cibles définis ont été atteints. Pour le faire, vous devez disposer de différents indicateurs liés aux fonctions et composantes du programme.

Les indicateurs s'expriment la plupart du temps en termes de facteurs numériques et aident à comparer la performance réelle aux résultats escomptés. C'est précisément à l'étape de planification que les indicateurs et toutes les activités de suivi / évaluation sont déterminées. Ainsi, tout plan qui ne comporte pas ces indicateurs suivis par des procédures de suivi / évaluation est incomplet et impossible à mettre en œuvre.

a. Indicateurs et étapes de leur formulation :

Le processus de formulation des indicateurs n'est pas une tâche facile. Elle comprend plusieurs étapes : L'identification des indicateurs qui sont considérés comme essentiels pour le suivi. Les indicateurs doivent pouvoir spécifier :

- La population cible (pour qui)
 - La quantité (combien)
 - La qualité (avec quelle performance)
 - Le lieu (où)
- **Définir chaque indicateur potentiel** pour fournir une description complète des données requises. Ceci inclura l'utilisation envisagée, le numérateur et le dénominateur, les sources et les méthodes de collecte de données, le personnel impliqué, la programmation (périodicité de mesure) et les limites.
 - **Sélectionner des indicateurs** sur la base de critères de faisabilité. Les indicateurs pour le suivi doivent être incorporés au plan lui-même et étroitement liés aux moyens disponibles pour la collecte et le traitement des données.
 - **Définir (adopter) les indicateurs** et établir un repère pour chacun d'entre eux pour utilisation en vue de mesures répétées à intervalles réguliers. Si l'indicateur est sélectionné pour la première fois, il est recommandé de le tester sur le terrain avant son adoption.

b. Types d'indicateurs :

L'objectif du programme de vaccination est d'atteindre une forte couverture vaccinale de la population cible à travers la prestation de services de qualité, à l'aide des ressources humaines, matérielles et financières disponibles, afin de réduire la morbidité et la mortalité, éliminer ou éradiquer les maladies avec les vaccins disponibles. Pour mesurer tous les paramètres ci-dessus dans le plan, les indicateurs de suivi sont classés en quatre domaines clés :

- **Indicateurs d'intrant** : ce sont des indicateurs préalables pour le processus de mise en œuvre, politiques de vaccination, contributions en ressources (humaines, matérielles, financières).
- **Indicateurs de processus** : ce domaine examine la fonctionnalité et la qualité du système de vaccination et comprend toutes les activités : planification, financement, qualité de la prestation de service, sécurité de la vaccination, évaluation du programme et de son efficacité, etc.
- **Indicateurs d'extrant** - couverture vaccinale et autres résultats ou produits en rapport avec les objectifs du programme.
- **Indicateurs d'impact** - réduction de la mortalité et de la morbidité des maladies ciblées.
- **Indicateurs de résultat** - liés à la réalisation du but final, ex. : Éradication de la polio, élimination du tétanos néonatal.

c. Sélection et utilisation des indicateurs :

Les considérations suivantes doivent être prises en compte lorsqu'on sélectionne des indicateurs :

- Dans quelle mesure la collecte des données pour l'indicateur est-elle **pratique et faisable**?
- Quelle est l'**importance** des informations fournies par un indicateur pour le processus global de mise en œuvre des domaines clés du programme ?
- Quelle est la **difficulté** de la méthode de mesure d'un indicateur particulier en termes de temps, d'argent et de complexité?
- Quelles sont les **qualités requises** de l'indicateur? Peut-il **mesurer** le niveau des réalisations ou les paramètres changeant d'une activité ? Peut-il aussi être utilisé pour **comparer les progrès** entre plusieurs périodes ou différentes zones où le programme est opérationnel ? Un indicateur peut-il fournir des explications pour effectuer une analyse efficace, ce qui fait partie du processus de suivi ?

Suivre tous les aspects du programme consommerait beaucoup de ressources (humaines, matérielles, financières). Par conséquent, le choix des indicateurs doit recevoir la priorité. Le gestionnaire du PNI doit pouvoir les adapter aux besoins du programme et sélectionner ceux qui sont les plus pertinents.

d. Critères de sélection des indicateurs :

En prenant l'exemple du DTC3/PENTA3, l'indicateur doit être :

- **Pertinent (approprié)** : traiter de la question ou du domaine de programme qui vous intéresse (ex. : le DTC3/PENTA3 est un indicateur pertinent à appliquer pour le suivi du programme de vaccination).
- **Sensible** : capter les variations de valeurs dans une gamme raisonnable (ex. : la proportion des enfants qui ont eu leur vaccination de DTC3/PENTA3 avant leur premier anniversaire. Quand nous faisons référence à la couverture DTC3/PENTA3, nous voulons toujours dire la tranche d'âge des enfants de 6 semaines à 1 an. Les enfants vaccinés au-delà de cette tranche ne sont pas comptés dans le cadre de l'indicateur de couverture DTC3/PENTA3).

- **Spécifique** : refléter un objectif ou cible spécifique (ex. : taux de couverture DTC3/PENTA3, qui se réfère spécifiquement à la proportion des enfants qui ont reçu leur 3ème dose de DTC, ou tout autre vaccin contenant du DTC, avant leur 1er anniversaire).
- **Techniquement** valide : être basé sur les informations technique les plus récentes (ex. : l'efficacité du DTC3/PENTA3 dans beaucoup d'essais épidémiologiques et cliniques. Pour avoir une protection suffisante contre la coqueluche, l'enfant doit recevoir 3 doses de vaccinations principales avec le DTC/PENTA).
- **Faisable pour la collecte** : trois sous-critères sont inclus :
 - les données sont facilement **disponibles** ou peuvent être recueillies avec des efforts supplémentaires raisonnables (fiches journalière de vaccination ou carnet de santé de l'enfant portant des informations sur le DTC3/PENTA3).
 - les données recueillies sont **fiables** (les rapports viennent d'une source officielle, ex. : les rapports de vaccination indiquant la couverture DTC3/PENTA3 proviennent de l'infirmier responsable du centre de santé). Ceci indique la **fiabilité de la source** (mais n'indique pas la **fiabilité technique** des données notifiées, qui peuvent être incomplètes ou contenir des erreurs. Les données ne peuvent être considérées comme fiables qu'après que la validation de données notifiées).
 - Les données sont **accessibles** (les chiffres DTC3/PENTA3 sont toujours présents dans les rapports mensuels au centre de santé, et sont accessibles au superviseur).
- **Simple et compréhensible** pour l'utilisateur (ex. : un professionnel de santé de la formation sanitaire peut facilement compter le nombre d'enfants qui ont reçu une troisième dose de DTC/ PENTA et ceux qui ont abandonné).
- **Vérifiable** : l'indicateur DTC3/PENTA3 est basé sur le nombre de doses administrées à partir des registres de la formation sanitaire. Les fiches registres sont conservées pour une période de temps spécifiée. Cette information peut être vérifiée si besoin.

e.Utilisation d'indicateurs :

L'utilisation d'indicateurs dépend de plusieurs facteurs :

- **But/type d'activité** : pour **suivre** votre plan ou programme, vous sélectionnerez et utiliserez essentiellement des indicateurs d'intrant et de processus, tandis que pour **l'exercice d'évaluation**, vous pouvez utiliser une large gamme d'indicateurs en mettant l'accent sur les indicateurs d'impact. Si un important plan de vaccination pluriannuel est en cours d'évaluation finale (ex. : Certification de l'éradication de la polio), utiliser les indicateurs de résultat.
- **Fréquence de l'activité** :
 - **Suivi quotidien/hebdomadaire**- chercher parmi les indicateurs d'intrant ou de processus les informations sur la disponibilité du personnel ou de matériel pour effectuer les activités quotidiennes ou observer comment votre personnel effectue les vaccinations. Un cas de maladie d'importance pour la santé publique ou une MAPI a-t-elle été signalée ?

Les cas suspects de MAPI ont-ils été investigués ? Si le système d'information nécessite une notification hebdomadaire des maladies infectieuses, quelle est la complétude de ces rapports hebdomadaires ? Les cas « zéros » sont-ils toujours notifiés comme c'est préconisé ?

- **Suivi mensuel/trimestriel/annuel**- sélectionnez les trois premières catégories d'indicateurs : intrant, processus et résultat, pour suivre la couverture vaccinale réalisée, la complétude et la promptitude des rapports et d'autres aspects du programme.

– Utilisation d'indicateurs par rapport aux composantes du plan

Il est souhaitable de décider d'intensifier le suivi dans **une ou plusieurs composantes** du plan pour surmonter certaines faiblesses. Dans ce cas, il faut choisir les indicateurs pertinents pour cette composante particulière, par exemple :

- Les indicateurs de suivi de la chaîne du froid.
- Les indicateurs de suivi des stocks des vaccins.
- Les indicateurs de suivi de la mobilisation de ressources
- Les indicateurs d'évaluation la mise en œuvre de la campagne, etc.

– Utilisation d'indicateurs par rapport au niveau du suivi/évaluation

Différents niveaux du système de santé (central, provincial ou formation sanitaire) peuvent utiliser le même indicateur. Toutefois, il y a certains indicateurs qui sont plus pertinents pour un niveau donné. A titre d'exemple l'indicateur de couverture DTC3/PENTA3 :

- Taux de couverture DTC3/PENTA3 : utiliser **pour tous les niveaux**.
- Nombre d'enfants non-vaccinés (avec le DTC3/PENTA3) : **utiliser dans les formations sanitaires**.
- % des formations sanitaires ayant une couverture DTC3/PENTA3 $\geq 95\%$; **utiliser au niveau provincial**.
- % des provinces ayant une couverture DTC3/PENTA3 $\geq 95\%$: **utiliser au niveau national ou provincial ou régional**.

f. Indicateurs pour le suivi et l'évaluation du programme de vaccination :

Les systèmes de santé utilisent des indicateurs pour suivre la mise en œuvre du plan de vaccination en termes de **couverture et de qualité des services de vaccination**.

- Le **niveau de couverture de chaque vaccin** (et de chaque dose du même vaccin) inclus dans le calendrier national de vaccination.
- Le **pourcentage des enfants complètement vaccinés de moins d'un an** : un enfant complètement vacciné de moins d'un an est l'enfant qui a reçu toutes les doses valides des vaccins selon le calendrier vaccinal.
- Le **pourcentage des femmes enceintes ayant reçu les doses adéquates du VAT**. C'est le nombre des femmes enceintes ayant reçu une ou autre dose du VAT pendant cette grossesse.

- Le **pourcentage des enfants nés protégés contre le TNN**. C'est une méthode alternative pour déterminer la couverture VAT-2+ (en particulier lorsque le VAT-2+ est peu fiable). Un enfant est dit protégé si la mère a reçu une dose valide de VAT-2+ (au moins deux semaines avant l'accouchement).
- **Nouveaux cas notifiés de PFA non-polio** : il se calcule en divisant le nombre des nouveaux cas (chez les enfants de < 15 ans) par le nombre du total des enfants de < 15 ans de la zone de couverture multiplié par 100 000.
- **Taux notifié du tétanos néonatal (TN)** : nombre de nouveaux cas de TN pour 1000 naissances vivantes : Il se calcule en divisant le nombre de nouveaux cas de tétanos néonatal par le nombre total de naissances vivantes multiplié par 1000.
- **Nouveaux cas notifiés de rougeole dans la population** : il se calcule en divisant le nombre des nouveaux cas de rougeole par le nombre total de la population dans la zone de couverture, le résultat multiplié par 1000.
- **Disponibilité des vaccins et accessoires** : il se calcule en divisant la somme des jours pendant lesquels chaque vaccin ou accessoire était disponible par le nombre total de jours de la période de référence, le résultat doit être multiplié par 100.
- **Taux de pertes** : BCG, PENTA1; PENTA3; RR1 ; VPI....
- **Complétude du rapport.**
- **Promptitude du rapport.**
- **Nombre de cas (ou incidence) d'autres maladies évitables par la vaccination.**
- **Taux d'investigation des cas/flambées** : nombre de cas/flambées notifiés des maladies cibles investigués, divisé par le nombre du total de cas/flambées des maladies cibles notifiés x 100.
- **Existence d'un système de détection et de notification des EIPV.**

g. Indicateurs essentiels :

Les cinq **composantes opérationnelles** du système de vaccination sont les suivantes :

- La **prestation des services**, qui couvre les stratégies et les activités d'administration des vaccins.
- La **logistique**, y compris la livraison des vaccins et des autres matériels au lieu d'utilisation, la fourniture de moyens de transport, la gestion de la chaîne de froid et l'élimination des déchets.
- La **fourniture et la qualité des vaccins** qui comprennent la prévision des besoins en vaccins, le contrôle de l'utilisation et de la sécurité des vaccins.
- La **surveillance de la maladie** qui comprend le suivi de l'incidence de la maladie, les examens de laboratoire, l'archivage et le compte-rendu.
- Le **plaidoyer et la communication** qui comprennent la mobilisation sociale, le plaidoyer, l'éducation communautaire sur la vaccination et la promotion du programme.

Les trois **éléments d'appui** du système de vaccination sont :

- Le financement durable comprend la budgétisation, l'identification des sources de financement, les actions qui mènent à l'allocation croissante des ressources financières aux activités de vaccination.
- La gestion comprend l'élaboration des politiques et la définition des normes, la planification, la coordination, la gestion de l'information, la collaboration avec les autres partenaires, l'assurance qualité, le suivi et l'évaluation.
- Le renforcement des ressources humaines et institutionnelles comprend la dotation en personnel, la formation, la surveillance, l'appui institutionnel (y compris la délivrance des informations techniques, l'appui aux projets de recherche et la génération des connaissances, etc.)

Pour couvrir le système de vaccination tout entier, toutes les composantes opérationnelles avec leurs éléments d'appui doivent être suivies, afin d'obtenir une image complète du programme

L'ensemble des indicateurs essentiels est **représentatif mais limité et peut être suivi au niveau national** à l'aide du système d'information sanitaire existant. Ces indicateurs :

- Fournissent un profil pratique et représentatif de l'état du programme national de vaccination ;
- Permettent le suivi de la performance du pays en fournissant les informations essentielles requises par tous les gestionnaires du PNI ;
- Permettent des comparaisons entre pays et le suivi du programme au niveau régional (OMS/EMRO) et mondial ;
- Donnent des indications sur les progrès vers les objectifs de vaccination.

Dans un effort visant à limiter la quantité d'informations requises et à éviter l'incohérence de l'information, les indicateurs essentiels sont inclus dans le rapport conjoint de l'OMS/UNICEF (JRF)¹, afin d'avoir une source uniforme d'informations sur les systèmes nationaux de vaccination

Toutes les informations contenues dans le JRF et que produisent les indicateurs essentiels doivent faire partie du Système national d'information sanitaire, sous forme intégrée ou à travers le suivi vertical du PNI. Cependant, tous les aspects du suivi du système national de vaccination ne sont pas inclus. Les responsables du programme ne sont pas limités à cet ensemble d'indicateurs essentiels, des choix supplémentaires peuvent être faits conformément aux objectifs spécifiques du programme national.

- Proportion de pays ayant un plan d'activités annuel national pour les services de vaccination.
- Proportion des pays ayant un plan de sécurité des injections comme composante du plan d'activités national.

4.6. Quantification des ressources et du budget :

a. Quantifier les ressources :

Les activités techniques et d'appui à mener identifiées, il faut déterminer pour chaque activité les ressources dont nous aurons besoin pour l'exécuter.

- Qui devra mener les activités de vaccination ?
- Avec quelles ressources ?

La détermination des ressources est une étape capitale qui vient répondre aux questions suivantes :

Les ressources sont généralement réparties en cinq catégories :

- Humaines.
- Matérielles.
- Financières.
- Informationnelles.
- Temps

Le plan doit préciser le montant de chaque ressource pour chaque activité en termes quantifiés.

b. Quantifier le budget :

Spécifiquement pour le PNI, le budget d'acquisition des vaccins est développé conjointement par le gestionnaire du PNI et l'administration des finances. Ce budget est sécurisé dans le volet investissement du budget général de l'Etat et l'acquisition des vaccins se fait via l'UNICEF selon des exigences particulières comme le critère « pré qualification » des vaccins par l'OMS.

Etape 1 : Quantifier les vaccins :

Évaluez les besoins en vaccins sur la base des éléments suivants : population cible ; objectif de couverture ; nombre de doses ; facteur de pertes.

Estimez les coûts sur la base des éléments suivants : prix unitaire.

Remplissez le tableau 3 en indiquant les fonds obtenus de chaque source en indiquant clairement les déficits (le cas échéant).

Tableau 3 : Calcul des besoins en vaccins pour la vaccination de routine

Vaccins	Population cible	Doses selon le calendrier de vaccination	Facteur de perte	Objectif de couverture	Stock de réserve	Durée de stockage	Besoin net	Observation
	A	B	C	D	E	F	G	H
BCG		1						
VPO		6						
....								
.....								

Résumé du procédé de calcul des vaccins nécessaires :

A = population cible, enfants de 0 à 11 mois, femmes enceintes ou femmes en âge de procréer.

B = doses requises par chaque antigène selon le calendrier de vaccination

C = facteur de :

- BCG = 2
- DTC = 1,33
- VPO = 1,33
- VPI = 1,11
- RR = 1,33
- HB = 1,33
- PENTA = 1,33
- VPC = 1,05
- ROTA = 1,05

D = objectif de couverture par province ou au niveau national.

E = Stock minimum de réserve (25% des doses requises pour la période) .

F = Durée de stockage (exemple présenté ci-dessus =4 mois).

G = Besoins nets .

Pour le calcul des coûts des vaccins, référez-vous à votre évaluation des besoins en vaccins, puis calculez le coût pour chaque antigène selon les prix qui vous sont communiquées chaque année.

Etape 2: Besoins pour la chaîne de froid.

- Les besoins relatifs à la chaîne de froid comprennent les éléments suivants : selon les référentiels du Programme : Chambres froides, réfrigérateurs/congérateurs, pièces de rechange, glacières, porte-vaccins, accumulateurs de froid, thermomètres, moniteurs de la chaîne de froid....
- Calculez ces coûts en vous servant des données sur la province ou l'établissement de santé.

Etape 3 : Besoins relatifs au transport et répartition des vaccins .

- Discuter votre stratégie de répartition des vaccins, puis élaborer un plan. Estimez le nombre et le coût des moyens de locomotion utilisés dans la province.
- Évaluez les besoins en carburant pour la distribution des vaccins et pour la stratégie mobile.

Etape 4 : Etablir un plan pour le matériel d'injection.

- Les estimations doivent être faites en tenant compte de la population cible pour chaque vaccin injectable, du nombre de doses requises et du facteur de pertes.

- Évaluez les besoins relatifs aux :
 - Seringues et aiguilles autobloquantes.
 - Seringues pour la dilution .

Exemple :

- Nombre de seringues pour le Penta = population cible x 3 doses x facteur de pertes.
- Pour les seringues autobloquantes, l'OMS recommande d'utiliser un facteur de pertes de 1,1.

Etape 5 : Elaborer un plan d'appui à la formation

- Précisez le nombre de sessions de formation et décrivez-en le type (ex. : atelier, sessions d'information etc.) ; spécifiez le nombre et les catégories de personnel à former, ainsi que la durée et le coût de chaque session.
- Décrivez et évaluez le coût de la formation.

Etape 6 : Elaborer un plan pour la surveillance des maladies

N'oubliez pas de tenir compte des éléments suivants lors de la planification des activités de la surveillance (questions également liées à la collecte, compilation, analyse, diffusion et rétro-information sur les données)

- Estimer les besoins en formation pour les épidémiologistes, les gestionnaires des données, les professionnels de santé.
- Estimer les besoins en matière de sensibilisation des professionnels de santé et des partenaires du CCI.
- Estimer les besoins en matière de supervision, de suivi et d'évaluation des activités de surveillance.

Etape 7 : Elaborer un plan pour l'appui de la supervision formatrice.

Par l'identification des thématiques ; des formateurs et du personnel à former, ainsi que l'élaboration d'un planning des activités de formation en concertation des partenaires et en tenant compte de la disponibilité du personnel.

Etape 8 : Planifier pour l'augmentation de la couverture dans les provinces à faible couverture.

Au cours de la décennie écoulée, certains pays en développement ont enregistré une baisse ou la stagnation de la couverture des activités de vaccination de routine. L'évaluation a aussi montré que certaines provinces sont moins performantes que d'autres. Par conséquent, certains pays ont porté leur attention sur les provinces à faible couverture en mettant à leur disposition des ressources supplémentaires pour améliorer leurs prestations.

La liste ci-dessous contient des suggestions visant à cibler les provinces à problème et à leur fournir l'appui et les ressources pertinentes.

- Identifier les provinces concernées et les notifier de la nécessité de déployer davantage d'efforts pour améliorer les résultats du PNI.

- Fixer des objectifs réalistes pour les provinces
- Discuter des stratégies possibles au niveau des provinces grâce à l'approche de résolution des problèmes (s'attendre à des solutions spécifiques aux provinces, même les plus inhabituelles)
- Définir les stratégies prioritaires : toutes les stratégies ne produiront pas les résultats attendus
- Veiller à ce que les provinces élaborent des micro-plans pour chacun des éléments suivants :
 - Vaccins.
 - Chaîne de froid.
 - Injections et stérilisation.
 - Formation.
 - Communication et mobilisation sociale.
 - Suivi et supervision.
- Discuter des micro-plans avec les responsables nationaux pour mobiliser des ressources supplémentaires.

Questions à examiner lors de l'élaboration des plans en faveur des provinces à faible couverture :

- Quelles sont les causes des mauvais résultats du programme dans les provinces et préfectures ?
- Quelles sont les priorités auxquelles il faut s'attaquer ?
- Quelles sont les solutions perçues de chaque problème identifié?
- Quels sont les avantages et les inconvénients de chaque solution ?

Les provinces et préfectures à faible couverture devront envisager la mise en œuvre des activités de routine et des activités de la vaccination supplémentaire susceptibles d'améliorer la couverture.

4.7. Utilisation du plan élaboré :

Il est demandé de transformer le plan élaboré en un plan d'activités ou plan d'action.

Le plan d'activités conçues par le gestionnaire et son équipe précise les activités planifiées, leurs durées (date de démarrage et de fin), les ressources nécessaires ainsi que les responsables d'exécution. Il constitue un outil précieux pour l'exécution, le suivi et l'évaluation du programme. Chaque plan annuel doit avoir son propre plan d'activités.

L'élaboration du plan d'activités se fait à tous les niveaux et en équipe. Il est diffusé et connu par l'ensemble des acteurs (plan opérationnel).

Pour élaborer un bon plan d'activités, il faut répondre aux questions suivantes

- Quels sont les objectifs ?
- Quelles sont les activités les plus importantes ?

- Quelle sera leur séquence de réalisation ?
- Quelles personnes seront chargées de les exécuter ?
- Où seront-elles exécutées ?
- Quels moyens seront disponibles pour leur exécution ?

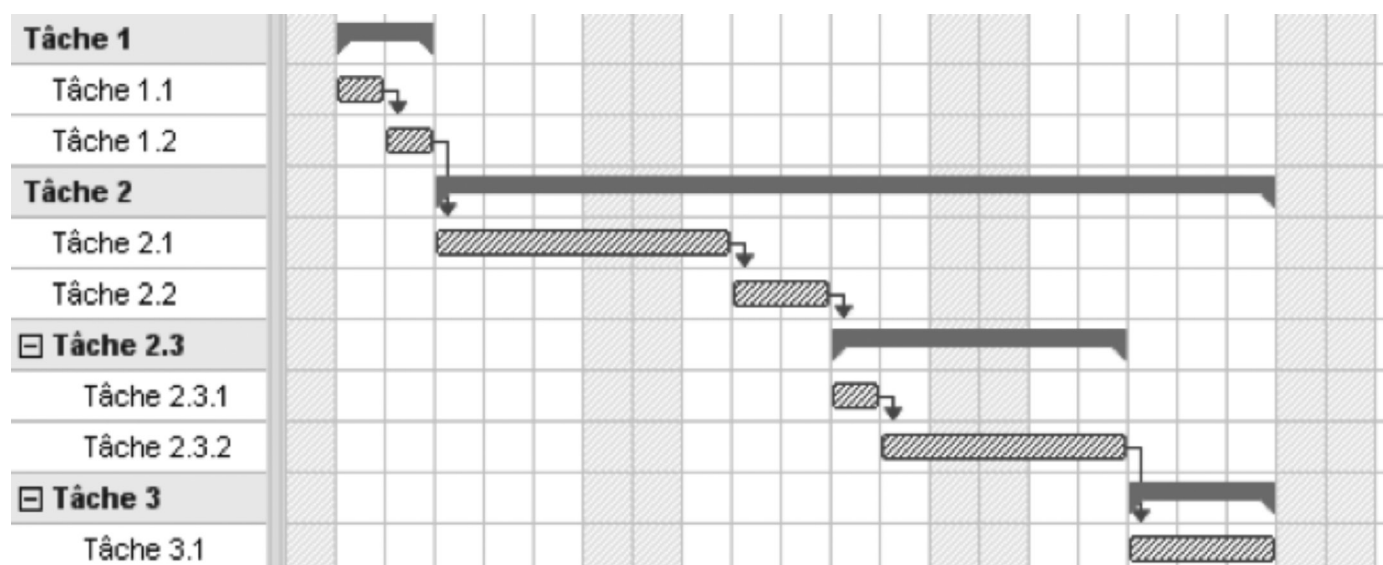
Il existe plusieurs techniques appelées techniques d'organisation ou de programmation. Les plus fréquemment utilisées de ces techniques sont le diagramme de GANTT et le programme d'évaluation et d'examen technique PERT.

Pour des besoins opérationnels, chaque gestionnaire du PNI doit au moins pouvoir construire un diagramme de GANTT (gratuitement téléchargeable sur l'internet)

Le diagramme de GANTT est un graphique à double entrée, une pour les activités à accomplir et l'autre pour leur période d'exécution. La durée d'exécution est représentée sous forme de bâtonnet horizontal lorsque l'activité dure un certain temps et sous forme de croix lorsqu'elle est ponctuelle et se déroule pendant une courte unité de temps, ex. : un jour.

Le plan fournit aussi le canevas dans lequel le gestionnaire peut travailler, c'est-à-dire le plan de travail sous forme du diagramme de Gantt, à partir duquel on peut mesurer la performance du programme.

Figure3 : Exemple de diagramme de Gantt



Chapitre 2

Planification des activités de vaccination pour l'augmentation de la couverture vaccinale.

I. Introduction :

1 .Contexte :

La couverture vaccinale, proportion d'individus vaccinés au sein de la population cible, est l'un des indicateurs les plus importants d'un programme de vaccination réussi. Les Plans stratégiques de l'OMS encouragent les pays à renforcer leurs systèmes de vaccination, accélérer la lutte contre la maladie et introduire de nouveaux vaccins et des innovations technologiques. Le plan envisage que d'ici 2020, au moins 90% des pays en développement de la Région auront une couverture vaccinale d'au moins 90% dans **toutes les Provinces**.

2. But :

Ce chapitre a pour but de doter les gestionnaires de programme aux niveaux national et déconcentré de compétences leur permettant d'aider les professionnels de santé au niveau périphériques à augmenter la couverture vaccinale. Ceci inclut l'utilisation des données locales pour identifier les problèmes et les causes de la faible couverture vaccinale et planifier des solutions pour augmenter la couverture vaccinale. Ce chapitre insiste sur la manière d'augmenter la couverture vaccinale en :

- atteignant ceux qui n'ont pas encore été vacciné (améliorer **l'accès**)
- réduisant les abandons (améliorer **l'utilisation**) .

D'autres aspects de l'augmentation de la couverture vaccinale peuvent être évoqués : supervision par les gestionnaires du PNI, rôle du gestionnaire du PNI, gestion de la chaîne de froid, etc.).

3. Objectifs de la formation :

Les participants seront en mesure de :

Compiler les données de couverture :

- Calculer le nombre total de doses de vaccin administrées à temps pendant la période précédente.
- Calculer le taux de couverture par antigène.
- Calculer le nombre d'enfants et de femmes non-vaccinés.
- Calculer les taux d'abandon .

Identifier et analyser les problèmes de couverture vaccinale et leurs causes

- Identifier les problèmes d'accès géographiques et leurs causes.
- Identifier les causes des abandons.
- Identifier les causes des occasions manquées.
- Classer les problèmes en deux catégories : accès ou utilisation.

Classer par priorité les activités et les domaines d'intervention

- Pouvoir sélectionner activités et les zones qui doivent être abordées en premier.

Planifier les activités en vue d'augmenter la couverture vaccinale :

- Préparer et mettre en œuvre un plan comportant des actions visant à augmenter la couverture.

Faire le suivi :

- Pouvoir effectuer le suivi des activités mises en œuvre.

II. Compilation des données démographiques et de couverture :

1. Description de la population et la zone à desservir :

L'obtention des informations relatives à la population et à la zone à desservir vous aidera à :

- déterminer pourquoi la population n'utilise pas les services de vaccination.
- identifier les moyens d'augmenter l'utilisation.
- planifier les activités des services de stratégie mobile.

Le type d'information que vous devez recueillir :

- Localisation du Centre de Santé, population totale, distances des rassemblements de la population aux centres de santé.
- Routes, climat et barrières saisonnières (ex. : routes inondées pendant la saison des pluies), barrières géographiques, ruisseaux, montagnes, délais de voyage.
- Autres barrières (divisions culturelles, ethniques, langue etc.) .
- Organisations culturelles, groupes communautaires, organisations non-gouvernementales.

2 .Calcul de la population cible annuelle :

Il y a deux types de populations de cibles annuelles : une pour les vaccins contre les maladies cibles des enfants et l'autre pour le vaccin antitétanique pour la femme en âge de procréer.

2.1. Vaccins pour enfants :

Pour calculer le nombre d'enfants nés en une année qui auront besoin de vaccination (BCG, PENTA, VPO, hépatite B, rougeole- rubéole), utilisez la formule suivante :

Nombre d'enfants de moins d'un an = population totale x p*/100

(* p = pourcentage des enfants de moins d'un an dans la population totale)

Exemple : Si la population totale est de 300 000 habitants et les enfants de moins d'un an représentent 3%, alors le nombre d'enfants de moins d'un an est 9 000 ($300\,000 \times 3/100 = 9000$).

Généralement les enfants de moins d'un an représentent 3-4% de la population totale. Si vous avez une estimation plus précise du recensement de la population, utilisez-la. Veillez à utiliser les statistiques démographiques officielles les plus récentes notamment celles fournies par la Direction de la Planification et des Ressources Financières du Ministère de la Santé.

2.2. Pour le vaccin antitétanique :

Les femmes en âge de procréer constituent la population cible du vaccin antitétanique. Toutefois, la population des « femmes enceintes » est utilisée pour suivre la tendance de l'administration du VAT. Pour des raisons pratiques, le PNI présuppose que le nombre de femmes enceintes est égal au nombre de naissances c'est-à-dire aux enfants de moins d'un an. Si vous n'avez pas les statistiques démographiques, vous pouvez utiliser la formule suivante pour déterminer la taille de la population cible :

Nombre de femmes enceintes = Population totale x p*/100

(* p = pourcentage des enfants de moins d'un an dans la population totale)

Exemple : Si la population totale est de 300 000 habitants et les enfants de moins d'un an représentent 3%, alors le nombre d'enfants de moins d'un an est de 9 000 ($300\,000 \times 3/100 = 9000$). Vous remarquerez que le nombre est le même que celui des enfants de moins d'un an.

* Référez-vous au tableau ci dessous.

- Inscrivez les chiffres de votre population cible : enfants de 0 à 11 mois (colonne b).
- Inscrivez le nombre de doses de vaccin administrées dans la tranche d'âge cible pendant le période de 12 mois précédente par exemple - tableau 5, PENTA1, PENTA3, rougeole- rubéole (colonne c à e).
- Calculez la couverture vaccinale de l'année précédente, par exemple : PENTA1, PENTA3, rougeole- rubéole, (colonnes f à h). Vous pouvez calculer la couverture pour tous les autres vaccins administrés (hépatite B, VAT1, VAT2+) et Vitamine A.

Nombre de femmes enceintes = Population totale x p*/100

(* p = pourcentage des enfants de moins d'un an dans la population totale)

Nom des C/S	Compilez les données						Analysez le problème						Classez la zone de priorité		
	Pop cible	Doses de vaccin administré			Couverture vaccinale		Non-vacciné (nbre)		Taux d'abandons		Identifiez les types de pro- blèmes			Catégorisez les problèmes	
		Penta1	Penta3	Rougeole	Penta1	Penta3	Rougeole	Penta1- Penta3	Penta1 - rou- geole	Accès	Utilisation				
	1 an >													Priorité 2,3 ,1	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p

Tableau 5 : Analyse des données de la province / préfecture Objectif augmenter la couverture vaccinale à plus de 95%

2.3 Calcul de la couverture vaccinale par antigène/vaccin :

- Pour déterminer le niveau de couverture, vous devez savoir :
- Le chiffre total de la population cible (le dénominateur), les enfants âgés de 0 à 11 mois¹ pour le BCG, le PENTA, le VPO, l'Hépatite B, la rougeole- rubéole, et les femmes enceintes qui reçoivent le vaccin antitétanique (VAT). Les chiffres les plus fiables doivent être utilisés : recensement national de la population ou les données régulièrement actualisées du registre de la zone locale.

Pour chaque vaccin, le nombre de doses administrées à la population cible dans une période donnée (le numérateur).

$$\text{Taux de couverture (\%)} = \frac{\text{Numérateur}}{\text{Dénominateur}} \times 100$$

Selon votre niveau de service, recueillez ces données en :

- Examinant les rapports réguliers des formations sanitaires.
- Examinant les registres disponibles à la cellule d'information sanitaire ou à la formation sanitaire.
- Obtenant des informations d'autres prestataires de santé ou gestionnaires des programmes sur leurs activités de vaccination.
- Calculant la population cible annuelle à partir du recensement démographique officiel.

Pour calculer la couverture vaccinale, divisez le nombre total de vaccinations administrées au cours de la période de 12 mois précédente par la population cible.

III. Gestion des problèmes :

1. Analyse des problèmes :

- Pour que la vaccination soit efficace dans la prévention des cas et des décès, chaque enfant doit être complètement vacciné. Il y a deux façons d'estimer l'impact de la vaccination :
- En mesurant la couverture vaccinale pour chaque vaccin, en comparant le nombre de doses administrées au nombre d'enfants cibles destinés à les recevoir.

En mesurant le taux d'abandon, en comparant le nombre d'enfants qui ont commencé à recevoir des vaccinations au nombre d'enfants qui ont reçu toutes les doses de vaccin exigées.

Les outils de collecte des données sont :

- La fiche journalière.
- Le registre de vaccination.
- La carte de vaccination.
- Les rapports du programme .

Après avoir déterminé la couverture vaccinale, vous devez interpréter les données par rapport aux cibles planifiées.

- Vous devez répondre aux questions spécifiques suivantes :
- Quelle est la couverture vaccinale par rapport aux objectifs?
- Quelle est la couverture vaccinale par rapport aux chiffres de la période précédente?
- Quels étaient les résultats de chaque formation sanitaire?
- Que pouvez-vous dire de l'accès physique (déduit de la couverture PENTA1)?
- Y a-t-il une différence entre les niveaux de couverture des divers vaccins administrés en même temps?
- Tous ceux qui ont accès continuent-ils à utiliser les services?

L'abandon est une comparaison entre le nombre d'enfants qui commencent à recevoir les vaccinations et le nombre d'enfants qui ne reçoivent pas les doses suivantes pour une vaccination complète.

Entre le BCG et le vaccin antirougeole- rubéole Entre le PENTA1 et le PENTA3

Entre le PENTA1 et le vaccin antirougeole- rubéole

Cette analyse vous permet d'identifier les problèmes auxquels sont confrontés les services de vaccination.

* A l'aide du tableau 5

1.1. Estimation du nombre annuel d'enfants non-vaccinés qui n'ont pas reçu le PENTA3 (colonne i) ou le vaccin antirougeole- rubéole (colonne j).

(b) Population cible-(g) Enfants vaccinés = (i) Enfants non-vaccinés dans la tranche d'âge avec le PENTA3.

1.2. Calcul du taux annuel d'abandons, PENTA1-PENTA3, PENTA1-rougeole- rubéole (colonnes k, l) ou pour toute autre combinaison de vaccins que vous avez choisie.

Taux d'abandon PENTA1-PENTA3 :

Taux d'abandon Penta 1-Penta 3 :

$$= \frac{\text{Penta 1(c)} - \text{Penta 3 (d)}}{\text{Penta 1(c)}} \times 100$$

Le seuil du taux d'abandon est 5%.

La qualité de « l'utilisation » (bonne ou mauvaise) en fonction des taux d'abandon (elle est « bonne » si on a un taux d'abandon dans la classe d'âge ciblée $< 5\%$ et mauvaise s'il est $> 5\%$; toutefois, vous pouvez décider d'utiliser pour les taux d'abandon des seuils plus bas ou plus élevés).

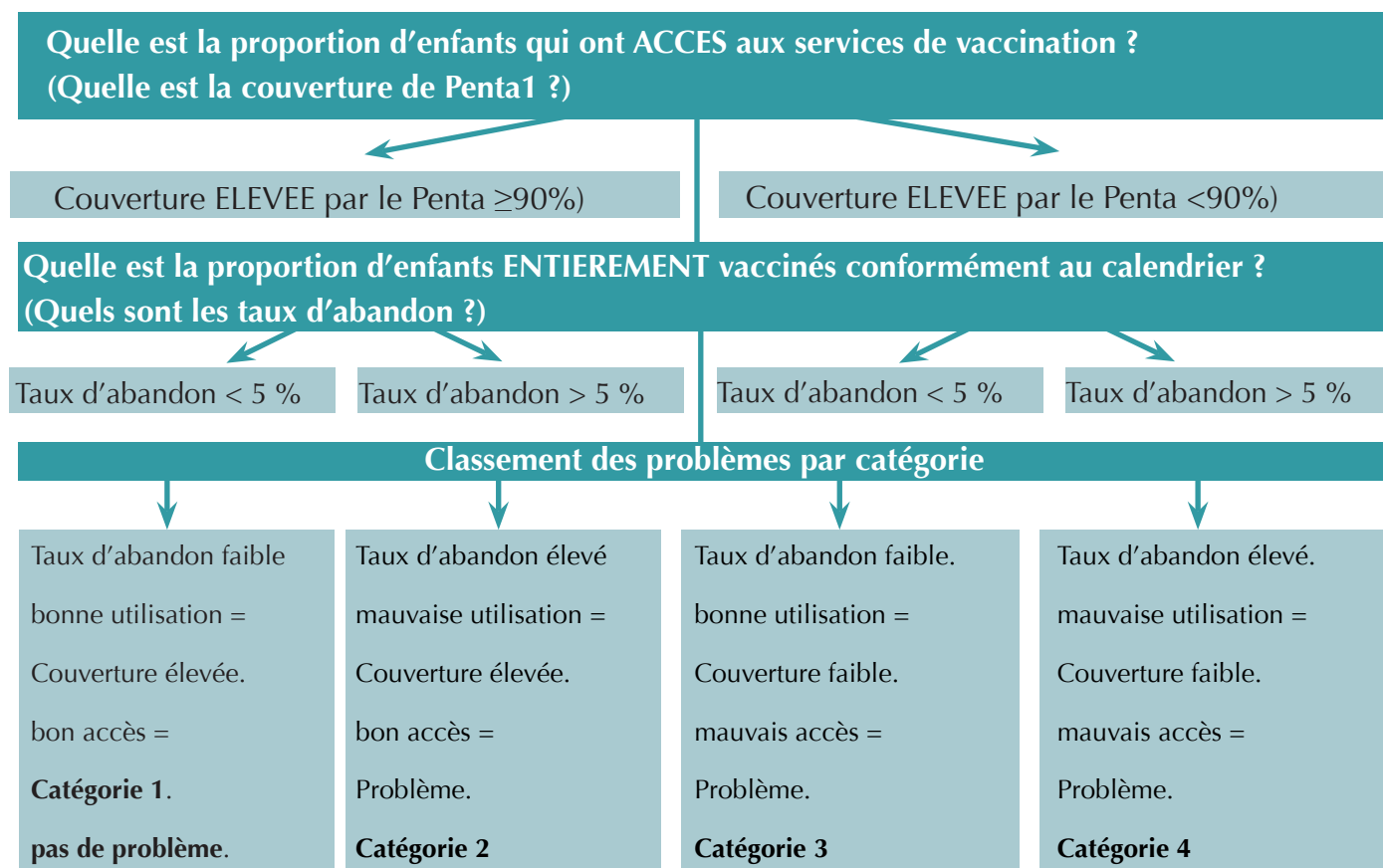
Pour corriger cette situation, vous devez d'abord identifier les problèmes existants et ensuite déterminer les causes de chaque problème.

- La faible couverture peut être causée par les groupes principaux de problèmes suivants:
- **L'inaccessibilité** (barrières géographiques et autres) : dans ce cas les enfants et les femmes ne sont pas atteints du tout ou n'utilisent pas du tout les services.
- **Les abandons** : ce groupe commence la vaccination, mais ne revient pas pour terminer le calendrier.
- **Les occasions manquées** : dans ce groupe, les enfants et les femmes ont eu un contact avec les structures de santé pour toute autre raison. Par exemple, une femme qui vient avec son enfant qui souffre de diarrhée, mais elle et son enfant n'ont pas été vaccinés par l'agent de santé.
- **L'ignorance** : dans ce groupe, certaines personnes ignorent l'existence des services de vaccination ou croient que la vaccination peut nuire pour des raisons socioculturelles.

L'observation de ces causes peut aider à identifier le type de problème qui aboutit à la faible couverture vaccinale :

Observation dans la CS	Diagnostic du problème
Forte couverture Penta 1, faible taux d'abandon	Pas de problème
Forte couverture Penta 1, taux élevé d'abandon	Problème d'utilisation
Faible couverture Penta 1, faible taux d'abandon	Problème d'accès
Faible couverture Penta 1, taux élevé d'abandon	Problème d'utilisation et d'accès

La figure 3 : présente toutes les options des taux d'abandon et de couverture vaccinale, classées en quatre catégories



Dans le tableau 5, marquez à la colonne « m » la qualité de l'accès (bonne ou mauvaise) selon la valeur de la couverture PENTA1 (« bonne » se définit, dans cet exemple, comme une couverture PENTA1 > 90% dans la tranche d'âge cible et « mauvaise » correspond à une couverture PENTA1 dans la tranche d'âge cible < 90%).

Marquez à la colonne « n » la qualité de « l'utilisation » (bonne ou mauvaise) selon la valeur du taux d'abandon (« bonne » se définit, dans ce cas, comme taux d'abandon = 5 % dans la tranche d'âge cible et « mauvaise » correspond à un taux d'abandon dans la tranche d'âge cible > 5 %).

Inscrivez le numéro de la catégorie du problème (1, 2, 3, 4) dans la colonne « o ».

Note : Rappelez-vous qu'une augmentation de l'accessibilité et donc une croissance de la couverture PENTA1 s'accompagnera initialement d'une montée des abandons. Toutefois, au cours des deux à trois mois suivants, si vous continuez à fournir le PENTA2 et le PENTA3 d'une manière systématique, vous noterez une amélioration graduelle des taux d'abandon.

2. Identification des causes des problèmes :

Pour identifier les causes des problèmes, il est important de s'entretenir avec la communauté desservie et le personnel de santé. Pour respecter le calendrier de vaccination, impliquez davantage la communauté en lui demandant comment lui rendre le service plus accessible. En outre, le personnel de santé doit chercher à savoir pourquoi les enfants ne commencent pas ou n'achèvent pas le calendrier de vaccination. Les entretiens et les observations pendant les supervisions fournissent aussi des indications utiles. En identifiant les causes de la faible fréquentation, il est toujours important de demander « mais pourquoi ? ».

En tant que groupe, classez les principales causes des problèmes liés au fort taux d'abandon et au mauvais accès dans votre formation sanitaire dans les catégories suivantes :

- Approvisionnement.
- Dotation en personnel.
- Prestation de services.
- Participation/demande communautaire.

3. Identification des solutions possibles :

Une fois que les causes de la faible couverture ont été identifiées, vous devez trouver des solutions appropriées pour les éliminer. Posez-vous les questions suivantes :

Quelles sont les solutions possibles?

- Sont-elles les plus appropriées?
- Les solutions proposées sont-elles réalisables?
- Qui mettra en œuvre ces solutions?
- Quelles ressources seront requises?

Le cadre présenté au tableau ci-dessous peut vous aider dans votre analyse.

Programme	Problème	Cause du problème	Solution avec les ressources existantes	Solution à l'aide des ressources supplémentaires
Ressources humaines et formation				
Vaccin et logistique				
Gestion et planification				
Communication				
.....				

Pour chaque problème, il peut y avoir plusieurs solutions possibles. Voici quelques exemples :

- Communication avec la communauté.
- Formation.
- Supervision.
- Mobilisation des ressources supplémentaires.
- Utilisation d'autres stratégies de vaccination, ex. : stratégie mobile, journées locales de vaccination, discussions thématiques de groupes, etc.
- Partenariat avec le secteur privé.
- Implication des ONG.

Tableau 6 : Quelques problèmes de faible couverture et leurs causes révélées pendant les discussions entre le personnel de santé et la communauté.

Problèmes	Causes possibles des problèmes	Solutions
Les parents n'amènent pas les enfants pour les vaccinations (problème d'utilisation-abandons)	1. Les professionnels de santé n'ont pas clairement expliqué aux parents quelles vaccinations sont dues, quand elles doivent se faire et pourquoi elles sont exigées. 2. Les professionnels de santé ne savent pas quels vaccins sont dus, quand il faut les faire et pourquoi ils sont exigés. 3. Les barrières découragent le retour des parents, telles que les heures d'ouverture du dispensaire, les longues attentes. 4. Les attitudes du personnel ne sont pas appropriées – ils ne respectent pas les parents ou ne s'intéressent pas à la santé de l'enfant. 5. Hésitation des parents pour la vaccination	
Les enfants et les mères ne sont pas vaccinés lorsqu'ils viennent au dispensaire parce que l'un d'eux est malade (problème d'utilisation - occasion manquée)	6. Les professionnels de santé oublient de vérifier les registres ou de demander quels vaccins et doses l'enfant/la mère a reçu. 7. Les professionnels de santé n'utilisent pas chaque contact avec les femmes en âge de procréer pour expliquer la nécessité et l'importance de la vaccination antitétanique et en particulier lorsqu'elles viennent faire vacciner leurs enfants. 8. Les professionnels de santé ne connaissent pas les contre-indications de vaccination. (Les professionnels de santé ne savent pas que les enfants ayant une maladie mineure peuvent être vaccinés.) 9. Les professionnels de santé n'expliquent pas aux parents qu'il est acceptable de vacciner un enfant ayant une maladie mineure. 10. Les vaccins ne sont pas disponibles ce jour-là.	
Les professionnels de santé ne peuvent pas déterminer les vaccinations qu'un enfant a reçu (problème d'utilisation-occasion manquée)	11. Les parents n'apportent pas le carnet de santé. 12. Les registres du dispensaire ne sont pas organisés pour faciliter la recherche des données d'un enfant. 13. Il n'y a pas de système de suivi dans le dispensaire.	

Les femmes enceintes ne cherchent pas à se faire vacciner contre le tétanos (problème d'utilisation)	14. Les barrières découragent des femmes de chercher vaccination, y compris le genre et les questions culturelles. 15. Les femmes ne savent pas qu'elles ont besoin de VAT.	
Les enfants ne reçoivent pas tous les vaccins qu'ils sont éligibles à recevoir pendant une visite (problème d'utilisation-occasion manquée)	16. Les professionnels de santé ne savent pas quelles vaccinations sont dues, quand elles sont dues et pourquoi elles sont exigées. 17. Tous les vaccins ne sont pas disponibles au dispensaire le même jour. 18. Les stocks de certains vaccins ne sont pas suffisants.	
Les enfants et les femmes enceintes ne viennent jamais au dispensaire pour commencer la vaccination (problème d'accès)	19. Le dispensaire est situé trop loin. 20. Les heures du dispensaire ne sont pas commodes ou ne sont pas connues par la communauté. 21. Les activités de stratégie mobile sont trop peu fréquentes ou la communauté n'a pas été correctement informée sur la programmation et le lieu (si stratégie mobile). 22. Les barrières culturelles, financières, raciales, de sexe ou autres empêchent l'utilisation des services de vaccination.	

IV. Elaboration du plan d'action pour les activités de vaccination :

1. Identification des activités de cette année :

Commencez à construire un plan d'action composé des activités à haute priorité que vous envisagez de mener cette année. Ces activités découlent de l'analyse des problèmes, des causes et des solutions que vous venez de proposer.

Pour le plan d'action vous aurez besoin d'objectifs réalistes pour la couverture vaccinale que vous pouvez atteindre à la fin de l'année. Si vous définissez bien votre objectif, vous avez une meilleure chance de l'atteindre. C'est pourquoi il est important que chaque formation sanitaire établisse ses objectifs en début d'année. Avoir des objectifs signifie savoir ce que vous voulez faire. Cela vous aide aussi à évaluer les progrès réalisés vers votre objectif et à être satisfait de votre travail. Par ailleurs, votre plan d'action déterminera aussi les ressources dont vous avez besoin pour mettre en œuvre les activités et les provenances escomptées.

2. Identification des Objectifs de couverture :

Les centres de santé doivent se fixer deux types d'objectifs :

- Objectifs de couverture pour les vaccinations infantiles (BCG, PENTA, VPO, Hépatite B, rougeole-rubéole, et tout autre vaccin fourni dans le cadre du PNI)
- Objectifs de couverture pour la vaccination avec le VAT2+ pour les femmes enceintes.

3. Définition des objectifs de vaccination :

3.1. Définition des objectifs de la vaccination infantile

Les objectifs de couverture pour la vaccination infantile sont définis pour une seule année et représentent l'augmentation minimale du pourcentage de couverture pour l'année en question.

Nous sommes arrivés au terme de l'année xxxx, et vous voulez définir les objectifs de xxxx+1 dans votre région/province/CS. L'objectif national est d'atteindre plus de 100 % de couverture d'ici xxxx+4.

Définissez les objectifs de couverture vaccinale pour une année pour les vaccins infantiles suivants : BCG, rougeole- rubéole, PENTA3, VPO3, Pneumo 3, HepB3. Pour le faire, suivez les étapes ci-dessous :

Étape 1. Déduisez la couverture actuelle dans votre zone de l'objectif national. Faites-le pour chaque vaccin.

Exemple:

Vaccin	Objectif national (%) d'ici 2020	-	Taux de couverture actuel (%) dans votre région	=	Différence (%)
BCG	100	-	65	=	35
PENTA3	100	-	35	=	65
VPO3	100	-	35	=	65
HepB3	100	-	35	=	65
Rougeole- ru- béole	1 70	100	-	=	=

Étape 2. Déterminez le nombre d'années entre l'année pour laquelle vous définissez actuellement les objectifs et l'année cible de l'objectif national.

Exemple : Il y a quatre années entre l'année xxxx et fin xxxx + 4

Étape 3. Divisez la différence entre votre couverture actuelle et l'objectif **national** par le nombre d'années entre l'année pour laquelle vous définissez les objectifs et l'année cible nationale. Vous obtiendrez l'augmentation minimale de votre taux de couverture pour chaque année.

Vaccin minimum	Différence entre la couverture vaccinale actuelle et l'objectif national	Nombre d'années qui séparent l'objectif national	Pourcentage annuel entre l'année de référence et l'année cible de l'objectif national
BCG	35%	4	9
PENTA3	65%	4	16
VPO3	65%	4	16
HepB3	65%	4	16
Rougeole- rubéole	70%	4	17

Étape 4. Ajoutez l'augmentation minimum du pourcentage de votre couverture chaque année au taux de couverture actuel dans votre **zone**. La somme de ces chiffres représente votre objectif pour l'année suivante.

Exemple :

Vaccin	Couverture(%) actuelle	+	Augmentation minimale annuelle (%) de la couverture	=	Objectif pour 2020 (%)
BCG	65	+	9	=	74
PENTA3	35	+	16	=	51
VPO3	35	+	16	=	51
HepB3	35	+	16	=	51
Rougeole- rubéole1	30	+	17	=	47

3.2. Définition des objectifs pour la couverture vaccinale du VAT :

L'administration du VAT aux femmes a pour but principal de protéger leurs bébés contre le tétanos néonatal, mais en même temps les femmes elles-mêmes sont protégées contre le tétanos.

Le calendrier de vaccination du VAT est plus complexe que celui des vaccinations infantiles. La période de protection contre le tétanos est différente pour chacune des cinq doses de VAT :

Si une femme a reçu	Période de protection
VAT1	Aucune protection
VAT2	années 3
VAT3	années 5
VAT4	années 10
VAT5	Aussi longtemps que la femme est en âge de procréer

L'objectif de couverture du VAT2 donne une idée du nombre des femmes enceintes qui doivent être vaccinées pendant l'année en question. Pendant la surveillance des activités de vaccination au VAT au cours de l'année et leur évaluation à la fin de l'année, cet objectif VAT2 servira de base pour évaluer les services des professionnels de santé.

Tout comme les objectifs de couverture fixés pour les vaccinations infantiles, l'objectif du VAT2 est un objectif annuel basé sur l'objectif national. Pour définir un objectif de couverture VAT 2+, suivez la procédure en 4 étapes décrites ci-dessus.

4. Stratégies de maintien de la couverture vaccinale de routine :

Les plans d'action de la Région, de la Province et du centre de santé doivent se focaliser sur les stratégies qui contribueront à améliorer et à soutenir la couverture de routine. Quelques stratégies pour surmonter les problèmes courants sont énumérées ci-dessous :

- Augmenter l'accès à la vaccination en s'assurant que toutes les formations sanitaires fournissent des services de vaccination et effectuent des activités appropriées de stratégie mobile.
- Saisir chaque occasion pour vacciner tous les enfants et les femmes éligibles.
- Organiser des activités spéciales telles que les semaines de la vaccination, surtout dans les zones ayant une couverture des services de santé faible ou de mauvaise qualité.
- Accroître la capacité des formations sanitaires à fournir des services de vaccination à travers la répartition du personnel et le développement des compétences. Toutes les formations sanitaires doivent avoir un personnel suffisant compétent dans la prestation des services de vaccination.
- Associer d'autres prestataires de soins de santé hors du Ministère de la Santé (ex. : secteur privé) dans la promotion de la vaccination.
- Stimuler la participation communautaire à travers l'implication des communautés dans la sensibilisation et la promotion de la vaccination, le suivi communautaire des abandons, l'éducation et le conseil des familles en matière de santé.
- S'assurer que toute la logistique de la vaccination est disponible en permanence et fonctionne correctement.

4.1. Stratégies de réduction des occasions manquées de vaccination

Selon le PNI, les stratégies suivantes permettent de réduire les occasions manquées :

- Approche de la Prise en Charge Intégrée de l'enfant (PCIE) : Utiliser les opportunités que les autres programmes qui sont inclus dans l'ensemble PCIE peuvent offrir pour la vaccination.
- Le contrôle du statut vaccinal de routine des enfants et des femmes ayant fait une consultation en externe.
- La connaissance des contre-indications réelles des vaccins.
- L'organisation des campagnes de rattrapage dans les endroits difficiles à atteindre
- Ouvrir plus de services de santé de stratégie mobile pour rapprocher les services des patients.

4.2. Stratégies de réduction des abandons :

Le programme PNI dispose des mesures suivantes pour réduire le taux d'abandon :

- Assurer l'approvisionnement continu en vaccins
- Lancer la mobilisation sociale sur l'importance et les avantages de la vaccination
- Ouvrir plus de services de santé de stratégie mobile pour couvrir les populations difficiles à atteindre
- Tenir les registres de vaccination complètement à jour.
- Créer un système de suivi des abandons au niveau de la formation sanitaire qui associe les professionnels de santé communautaires et les ONG locales.

V. Suivi :

La comparaison de ce que vous avez réalisé avec vos cibles comprend plusieurs étapes. D'abord vous planifiez votre programme et fixez vos cibles. Ensuite vous exécutez les activités de votre programme et enregistrez vos résultats. Puis vous comparez vos résultats avec vos cibles à partir de vos fiches récapitulatives de vaccination. Vous pourrez ainsi savoir où vous en êtes ? Ce processus s'appelle le suivi.

Le suivi signifie l'observation continue et la collecte de données sur le programme de vaccination pour s'assurer qu'il progresse comme prévu.

Le suivi peut être quotidien, mensuel ou trimestriel. Pour s'assurer que les objectifs sont atteints à temps, il est essentiel de suivre les progrès au moins chaque mois. La fonction la plus importante à suivre est celle relative aux tendances de la couverture vaccinale et les taux d'abandon au niveau local. Ils doivent être comparés avec la période précédente et l'objectif prévu.

1. Outils de suivi :

Pour effectuer un bon suivi, vous avez besoin de bons outils :

- Le carnet de santé de l'enfant
- Le registre de vaccinations
- Les feuilles de pointage de la vaccination
- La fiche récapitulative mensuelle de la vaccination
- Les rapports d'enquêtes sur la couverture vaccinale
- Le graphique de suivi de la vaccination
- Les rapports mensuels sur la vaccination et les maladies cibles et autres.

L'un des meilleurs outils de suivi de la couverture vaccinale est le graphique de suivi de **la vaccination** qui montre les progrès que l'équipe locale fait dans l'augmentation de la couverture vaccinale dans

la zone de couverture du centre de santé. Ce graphique permet de comparer le nombre de personnes réellement vaccinées chaque mois avec les cibles de couverture. Chaque vaccin, même chaque dose du même vaccin, peut avoir un graphique de suivi. Pour qu'il soit facile à lire, il est recommandé de ne pas localiser plus de deux composantes de vaccin dans un graphique. Cela facilitera le suivi simultané des progrès de la vaccination pour deux composantes ainsi que le calcul des taux d'abandon entre elles. Par exemple, vous pouvez enregistrer le PENTA1 et le PENTA 3 dans un graphique et suivre les résultats des districts cibles du PENTA3 et les taux d'abandon PENTA1-PENTA3.

Le graphique de suivi de la vaccination résume l'information donnée dans les rapports mensuels de vaccination. Si les rapports ne sont pas complets pour un district, le chiffre cumulatif de la couverture vaccinale baissera et ne reflétera pas la situation réelle. Le graphique de suivi de la vaccination sera affecté, puisque la ligne montrant votre performance réelle sera bien en dessous de votre ligne cible prévue. D'où la nécessité de suivre la complétude des rapports en même temps que celle de la couverture vaccinale.

La formation sanitaire est le meilleur endroit pour utiliser ce graphique, mais il peut aussi être utilisé à un niveau plus élevé (Province, Région et Central).

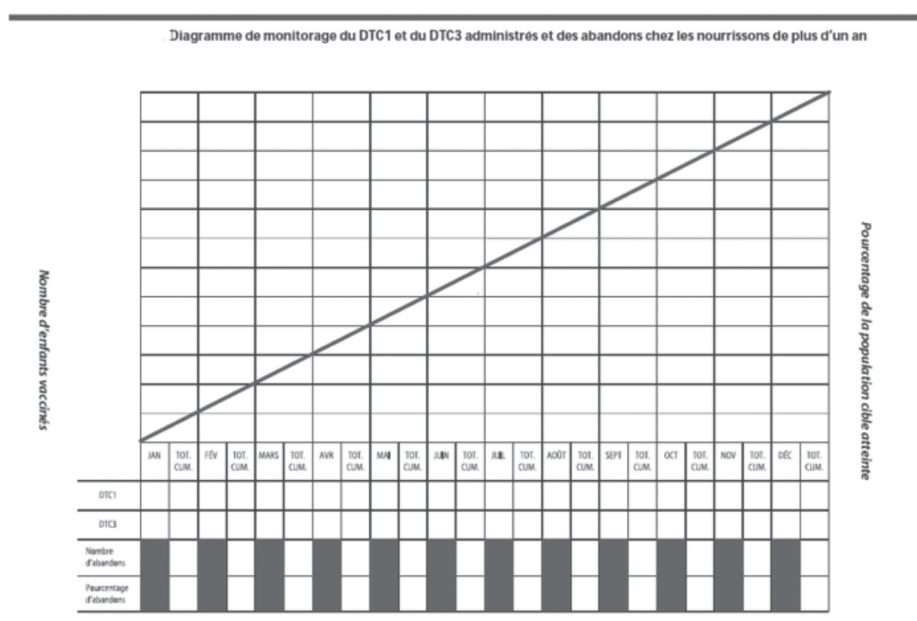
Il est recommandé de garder les graphiques et les autres outils de monitoring dans votre bureau pour suivre la performance de la couverture vaccinale et les taux d'abandon dans votre district.

Faites la mise à jour régulière de votre graphique quand vous avez des nouvelles données des formations sanitaires.

Identifier les formations sanitaires avec problèmes.

Donner plus d'appui aux formations sanitaires qui n'ont pas de bonnes performances.

La figure 4 : Graphique de suivi de la vaccination



2 .Supervision des activités de vaccination :

Il est capital de surveiller la qualité des activités vaccinales à tous les niveaux en vue de contribuer à l'atteinte d'une couverture vaccinale très satisfaisante. Il faut étudier les rapports émanant de la supervision régulière et ponctuelle effectuée par le personnel Central, Régional, Provincial et surtout Local (médecin chef et major de la CS). La rétro-information immédiate est une composante essentielle de la supervision. La supervision des activités du PNI doit être conçue et perçue comme un moyen pour:

- Encourager le personnel à exécuter les activités vaccinales selon les normes retenues ;
- Evaluer les performances réalisées en les comparant avec les objectifs fixés à tous les niveaux: localité, secteur, circonscription sanitaire, province, région et pays ;
- Détecter à temps les raisons des défaillances afin d'y remédier immédiatement ;
- S'assurer de la capacité de l'application des nouvelles instructions.

2.1-Les principes d'une supervision efficace:

- La supervision suppose l'analyse des problèmes identifiés et la recherche des solutions adéquates en concertation avec le personnel supervisé ;
- La supervision doit être planifiée, annoncée et continue ;
- la supervision doit être perçue comme un moyen de soutien et de formation continue ;
- La supervision doit privilégier les rapports humains et utiliser les habiletés fondamentales de la communication interpersonnelle ;
- La rétro-information donnée au cours et à la fin de la supervision doit privilégier les aspects positifs, encourager d'abord, puis faire les remarques nécessaires avec tact.

2.2-Ce qu'il faut superviser dans le cadre du PNI:

L'aptitude du personnel à:

- L'élaboration et la mise à jour du plan d'action et des tableaux de bord ;
- La gestion du matériel d'injection et de stérilisation ;
- La gestion de la chaîne du froid ;
- La gestion des vaccins ;
- L'organisation et le déroulement de la séance de vaccination ;
- L'offre des prestations vaccinales ;
- L'offre des prestations IEC accompagnant l'acte vaccinal;
- L'utilisation et la tenue des documents et supports d'information:
 - Les registres de vaccination (femmes et enfants) .

- Les fiches journalières d'activités.
- Les cartes de vaccination et carnets de santé (enfants et femmes) .
- Le registre de relevé de température et de gestion des vaccins.
- Le registre de gestion du matériel.
- Le rapport mensuel d'activités.
- Les rapports de supervision des échelons inférieurs.
- L'auto-évaluation continue.
- La destruction des flacons vides et du matériel à usage unique.
- Le diagramme de monitoring.
- Le registre des cas notifiés.

N.B: Le superviseur doit s'intéresser également aux connaissances du supervisé relatives au programme.

2.3-Les techniques de supervision

La conduite de la supervision fait appel à une méthodologie utilisant un certain nombre de techniques:

- L'observation passive: le superviseur observe sans intervenir et donne un feed-back à la fin ;
- l'observation / participation : le superviseur observe l'activité et intervient à chaque fois qu'il est nécessaire en démontrant l'attitude correcte ;
- L'entretien: le superviseur échange des informations avec les supervisés sur les problèmes rencontrés et sur leurs préoccupations. Il peut être utilisé comme complément de l'observation ou comme une technique à part ;
- La discussion du groupe: séance pendant laquelle le superviseur pose toutes les questions utiles concernant le programme et qui subsistent après l'observation et l'entretien ;
- L'exploitation des documents: le superviseur et le supervisé analysent les documents et supports d'information du Programme.

3 .La vérification de la qualité des données :

Rechercher les problèmes de la qualité des données qui suivent et prendre les dispositions nécessaires pour améliorer cette qualité :

- Taux de couverture supérieur à 100 % (peut-être à cause d'un problème de dénominateur) ;
- Importante variation mensuelle dans le total des doses administrées (peut indiquer un problème de compte-rendu, par exemple toutes les feuilles journalières ont-elles été correctement remplies ?) ;
- Taux d'abandon négatif – certaines doses ne sont pas pointées correctement, ou il y a des nourrissons qui reçoivent le Penta1 dans un centre de santé et le Penta2 et le Penta3 ailleurs, ou

- des enfants plus âgés ont été inclus dans le décompte du Penta3 ;
- Différence observée dans le nombre des doses administrées, pour des vaccins théoriquement donnés en même temps, par exemple le Penta1 et le VPO1, les vaccins anti rougeoleux, etc. ;
 - Non-concordance entre le nombre de personnes vaccinées et le nombre de flacons utilisés au cours de la période ;
 - Diminution de l'effectif de la population cible par rapport aux années précédentes.
 - La plupart de ces problèmes peuvent être réglés par une bonne tenue des dossiers et un système de notification de qualité (registre, feuilles journalières de pointage, registres de notification).

Référence :

- Building national capacity to reach every district with immunization services within the context of health sector priorities (GAVI, Oct. 2002)
- EPI Planning Guide (WHO/AFRO.2002)
- Expanded Programme on Immunisation (EPI) in the African Region: Strategic Plan of Action 2001-2005 (WHO March, 2001).
- Fielden, R. and Nielsen, O.F. Immunisation and health reform : Making reform work for immunization. A reference guide. (WHO/GPV/EPI. July 1998)
- Guide de vaccination 2008, Ministère de la santé , Maroc
- Guidelines for creating functional Interagency Coordination Committees, 2002
- Immunisation Policy. Doc. (WHO GPV/GEN/95.03.1995).
- Planning immunization Activities (WHO 1991).
- Reaching Every Province, building national capacity to reach every province with immunization services within the context of health sector priorities (GAVI, 30 Oct. 2002. Access WG Paper - LV1)
- Resources for Immunization Managers, CD version 2 (WHO/HQ, 2002)
- WHO Policy Statement : The use of opened multi-dose vials of vaccine in subsequent immunisation session, (WHO Geneva, 2000. Doc. WHO/V&B/00.99)
- Cours de formation en gestion des cadres du PEV Niveau intermédiaire: Bloc II : Planification/Organisation mars 2004 <http://who.int/vaccines-diseases/epitraining>